

SOMMAIRE

Sommaire -----	01
Appel à la lutte contre le covid-19-----	02
Code de conduite -----	03
Liste des abréviations-----	04
Monitoring des activités -----	06
Budgétisation des ressources d'un ESPC -----	15
Organisation de la référence/ Contre référence -----	20
Organisation et fonctionnement du Coges -----	23
Gestion de l'information sanitaire -----	29
Gestion des catastrophes naturelles/ Epidémies-----	43
Participation communautaire -----	46
Supervision -----	48
Suivi & évaluation des programmes Indicateurs et sources de données-----	56
Organisation d'une séance de vaccination-----	63

APPEL A LA LUTTE CONTRE LA COVID-19 ET TOUTE MALADIE CONTAGIEUSE

Je suis étudiant de l'INFAS ; je dois me comporter en
PROFESSIONNEL DE SANTE, éducateur pour la santé.

C'est pourquoi je m'engage et j'exhorte tous mes camarades étudiants
à respecter rigoureusement les mesures préventives recommandées
pour freiner la propagation de la pandémie à **COVID-19** et les autres
MALADIES CONTAGIEUSES pour :

-  Ma santé
-  Mes amis de classe
-  Mon établissement
-  Mon terrain de stage
-  Ma famille
-  Mon quartier et mon milieu de vie
-  Mon pays, la Côte d'Ivoire

Il s'agit de :

1. Me laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou passer mes mains au gel hydro alcoolique.
2. Me tenir à une distance à une distance d'au moins un (01) mètre des autres.
3. De porter un cache-nez dans tous mes déplacements.
4. Eviter de serrer les mains en saluant.

CODE DE CONDUITE

Je suis étudiant de l'INFAS

Je m'engage à **BIEN FAIRE TOUT CE QUE JE DOIS FAIRE**

Je m'oblige à un comportement **CITOYEN, HONNETE et DIGNE**

C'est pourquoi, **JE NE DOIS POINT :**

-  Manquer les cours en classe et en ligne
-  Tricher lors des compositions et examens pendant ma formation
-  Négliger les stages
-  Manquer les compositions et les corrections en classes et en ligne
-  Manquer de respect à mes enseignants ou encadreurs à l'école comme en stage
-  Participer à toute action pouvant perturber ou retarder ma formation
-  Voler les objets en classe ou en stage
-  Faillir à aucun point de la charte de l'étudiant que j'ai signée dès mon entrée à l'INFAS
-  Manquer aux dispositions disciplinaires de l'INFAS sur les terrains de stage

Je m'expose aux sanctions disciplinaires qui s'imposent si je faillis à ces engagements

LISTE DES ABRÉVIATIONS ET ACCRONYMES

ASC	Agent de Santé Communautaire
AT	Accoucheuse Traditionnelle
BCG	Bacille de Calmette et Guérin
CPN	Consultation Prénatale
CSE :	Centre de Surveillance Epidémiologique
DOTS:	Directly Observed Treatment, Short-course
DTC-HepB-Hib	Diphtérie Tétanique Coqueluche Hépatite B Haemophilus Influenzae
ESPC	Etablissement Sanitaire de Premier Contact
FJ	Fièvre Jaune
HG	Hôpital Général
IEC/CCSC	Information Education Communication/Communication pour le Changement Social de Comportement
PNLT	Programme National de Lutte contre la Tuberculose
RR	Rougeole Rubéole
SSP	Soins de Santé Primaires
TB/VIH	Tuberculose/Virus de l'immunodéficience Humaine
TC	Taux de Complétude
TDO	Traitement de courte Durée directement Observable
TP	Taux de Promptitude
VAA	Vaccin Anti Amaril
VAR	Vaccin Anti Rougeoleux
VAT	Vaccin Anti Tétanique
VPO	Vaccin Polio Oral

MONITORAGE ET L’EVALUATION DE LA COUVERTURE DES ACTIVITES

Objectif général

Ce cours vise à permettre à l'étudiant IDE/SF/M de la L3 de réaliser le monitoring et l'évaluation de la couverture des activités d'un ESPC

Objectifs spécifiques

A la fin du cours, il doit être capable

- 1) Définir les termes liés au monitoring et à l'évaluation
- 2) Décrire les quatre caractéristiques clés d'un bon indicateur pour le monitoring et l'évaluation des activités.
- 3) Expliquer les déterminants de la couverture pour le monitoring et l'évaluation des activités.
- 4) Représenter les valeurs des indicateurs sur un diagramme de couverture
- 5) Analyser les différents goulots d'étranglement pour ressortir les causes probables et les stratégies de résolution.

I.GÉNÉRALITÉS

Dans le cadre de la politique de mise en œuvre des Soins de Santé Primaires notamment de la stratégie de suivi de l'enfant et de la femme enceinte, la Côte d'Ivoire avec l'appui des partenaires au développement attache une grande importance au processus de monitoring de couverture des activités.

Le monitoring permet d'évaluer localement la couverture des activités à partir des déterminants de la couverture. Il s'effectue périodiquement tous les six mois. Il permet d'identifier les problèmes de fonctionnement et de gestion qui entravent la bonne exécution des activités, d'analyser leurs causes, de déterminer et de planifier ensemble les mesures correctrices à mettre en œuvre par les agents de santé et la communauté locale en tenant compte des ressources disponibles.

II.DÉFINITIONS OPÉRATIONNELLES DES TERMES LIES AU MONITORAGE

✓ Monitoring

Le monitoring est une activité qui permet de suivre l'avancement d'un programme. Il consiste à identifier les difficultés qui empêchent l'atteinte des objectifs au fur à mesure qu'ils se posent, et d'apporter des solutions correctrices pendant le temps imparti à l'exécution de cette activité.

✓ **Evaluation**

L'évaluation est une activité qui permet dans le cadre du monitoring à un moment donné, de déterminer quel groupe a bénéficié du programme, dans quelle mesure et comment ?

✓ **Critère ou déterminant de la couverture**

C'est une caractéristique recherchée par un programme et qui doit être appréciée au cours du monitoring et de l'évaluation des activités.

Les déterminants de couverture retenus dans le cadre du monitoring et de l'évaluation des activités sont

- La population cible ;
- La disponibilité des ressources ;
- L'accessibilité géographique ;
- L'utilisation des services ;
- La couverture adéquate :
- La couverture effective :

2.4 Indicateur

C'est une variable qui permet de mesurer les critères retenus dans le monitoring d'une activité

2.5 Couverture

C'est la population qui a bénéficié des activités d'un programme ou d'une action de santé.

2.6 Goulot d'étranglement

C'est un problème rencontré lors du monitoring et qui nécessite une action correctrice.

2.7 Diagramme de couverture

C'est la représentation graphique des valeurs des indicateurs

III-CARACTÉRISTIQUES CLÉS D'UN BON INDICATEUR

Un bon indicateur doit être :

Valable : c'est-à-dire qu'il doit effectivement mesurer, ce qu'il est censé mesurer.

Fiable : c'est-à-dire que sa valeur doit être la même si deux personnes la mesurent.

Approprié : c'est-à-dire qu'il doit être adapté au contexte local.

Mesurable : c'est-à-dire qu'il peut être mesuré à partir des données et des instruments simples.

IV. LES DÉTERMINANTS DE LA COUVERTURE

4.1 La population cible (PC) : c'est la population qui bénéficie d'un programme ou d'une activité donnée. Elle se calcule en tenant compte de la période couverte par le monitoring.

Exemple : Le centre de santé de Bazré a une population totale de 10.500 habitants en 2020. La période retenue pour le monitoring de l'activité de prévention de l'anémie chez les femmes enceintes part du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020 soit 6 mois.

La population cible du monitoring va se calculer selon les étapes suivantes :

- **Etape 1** : Identifier la proportion des femmes enceintes : 5% de la population totale.
- **Etape 2** : Calculer la PC annuelle = $10500 \times 5 / 100 = 525$ femmes enceintes
- **Etape 3** : Calculer la PC du monitoring = $525 / 2 = 263$ femmes enceintes .

La PC annuelle est divisée par 2 parce que la période retenue pour le monitoring est de 6 mois.

4-2 La disponibilité des ressources.

La disponibilité des ressources peut être définie comme la quantité des ressources essentielles existantes par rapport à la quantité des ressources essentielles requises pour couvrir la totalité de la population cible pour une intervention donnée.

Exemple : En vous servant de la population cible des femmes enceintes ci-dessus calculée, la quantité totale de fer nécessaire pour que chaque femme enceinte reçoive toute la quantité de fer dont elle a besoin pendant la grossesse se calcule comme suit :

Chaque femme enceinte reçoit selon les directives 30 gelules de complément ferrique par mois. Ainsi, elle recevra au total 270 gelules pendant toute la grossesse c'est à dire 30 x 9 mois (9 mois représente la durée de la grossesse).

La quantité de fer requise sera égale : 270 cp x 263 (263 est la population cible des femmes enceintes), ce qui donne un total de 71.010 cp. Cette quantité est appelée **quantité essentielle de ressources requises**

Supposons que la quantité du fer en stock dans le centre à la veille du monitoring soit égale à 25.000 gelules. Cette quantité en stock est appelée **quantité de fer essentielle existante**

Le calcul de la disponibilité des ressources se fera comme suit :

$$DR = \frac{\text{Quantité de fer essentielle existante}}{\text{Quantité de fer essentielle requise}} \times 100$$

$$DR = \frac{25000}{71010} \times 100 = 35\% \text{ (considérer la partie entière sans arrondir)}$$

4.3 L'accessibilité géographique

L'accessibilité géographique se définit comme le pourcentage de la population cible qui habite dans un rayon spécifique du lieu de prestations où les ressources sont disponibles. Selon l'OMS, la population qui a accès à un service de santé est celle qui habite dans un rayon de moins de 5km autour du centre de santé plus celle qui a bénéficié d'au moins une stratégie avancée pendant la période du monitoring.

Exemple : Supposons que 250 femmes enceintes de la localité habitent dans un rayon de moins de 5 km du centre de santé

Le calcul de l'accessibilité géographique se fera comme suit :

$$AG = \frac{\text{Effectif de femmes enceintes habitant dans un rayon de moins de 5 km du centre de santé}}{\text{La population cible du monitoring}} \times 100$$

$$AG = \frac{250}{263} \times 100 = 95 \%$$

4-4 L'utilisation de servive

L'utilisation des services peut être définie comme le pourcentage de la population cible qui utilise le service au moins une fois au cours de la période couverte par le monitoring. Dans notre cas, les femmes enceintes qui auront utilisé le service de CPN sont celles qui auront reçu au moins une dose de fer des mains de la sage femme pendant la période retenue pour le monitoring.

Exemple : Considerons que 200 femmes enceintes ont reçu au moins une dose de fer des mains de la sage femme pendant la période du monitoring.

L'utilisation de service se calcule comme suit :

$$US = \frac{\text{Nbre de femmes enceintes ayant reçu au moins une dose de fer pendant la période du monitoring}}{\text{La population cible du monitoring}} \times 100$$

$$US = \frac{200}{263} \times 100 = 76 \%$$

4.5 La couverture adéquate

La couverture adéquate peut être définie comme le pourcentage de la population cible qui utilise les prestations avec la fréquence et l'intensité (critère quantité) requises.

Ici les femmes enceintes qui ont une couverture adéquate sont celles qui auront pris le fer pendant toute la durée de la grossesse.

Exemple : Spposons que 55 femmes enceintes ont pris le fer pendant toute la durée de leur grossesse.

$$CA = \frac{\text{Nbre de femmes enceintes ayant pris le fer pendant toute la durée de leur grossesse}}{\text{Population cible du monitoring}} \times 100$$

$$CA = \frac{55}{263} \times 100 = 20 \%$$

4.6 La couverture effective

La couverture effective peut être définie comme le pourcentage de la population cible ayant reçu les prestations en quantité suffisante (couverture adéquate) et avec une qualité qui correspond aux normes établies scientifiquement comme nécessaires pour avoir l'effet escompté.

Dans notre cas, les femmes enceintes qui ont une couverture effective sont celles qui auront pris le fer non seulement durant toute la durée de la grossesse, mais selon les directives nationales (c'est à dire 1cp/j pendant toute la durée de la grossesse)

Exemple : Supposons que 40 femmes enceintes ont pris le fer pendant toute la durée de la grossesse selon les directives nationales.

Le calcul de la couverture effective se fera comme suit :

$$CE = \frac{\text{Nbre de femmes enceintes ayant pris le fer pendant toute la durée de la grossesse selon les directives nationales}}{\text{Population cible du monitoring}} \times 100$$

$$CE = \frac{40}{263} \times 100 = 15 \%$$

V. DIAGRAMME DU COUVERTURE

C'est la représentation graphique des valeurs des indicateurs. Il comprend une ligne des ordonnées (ligne verticale) sur laquelle sont notés les déterminants de la couverture et une ligne des abscisses (ligne horizontale) sur laquelle les valeurs des indicateurs sont mentionnées.

A partir des indicateurs ci-dessus calculés, tracer dans la figure ci-dessous la courbe de couverture

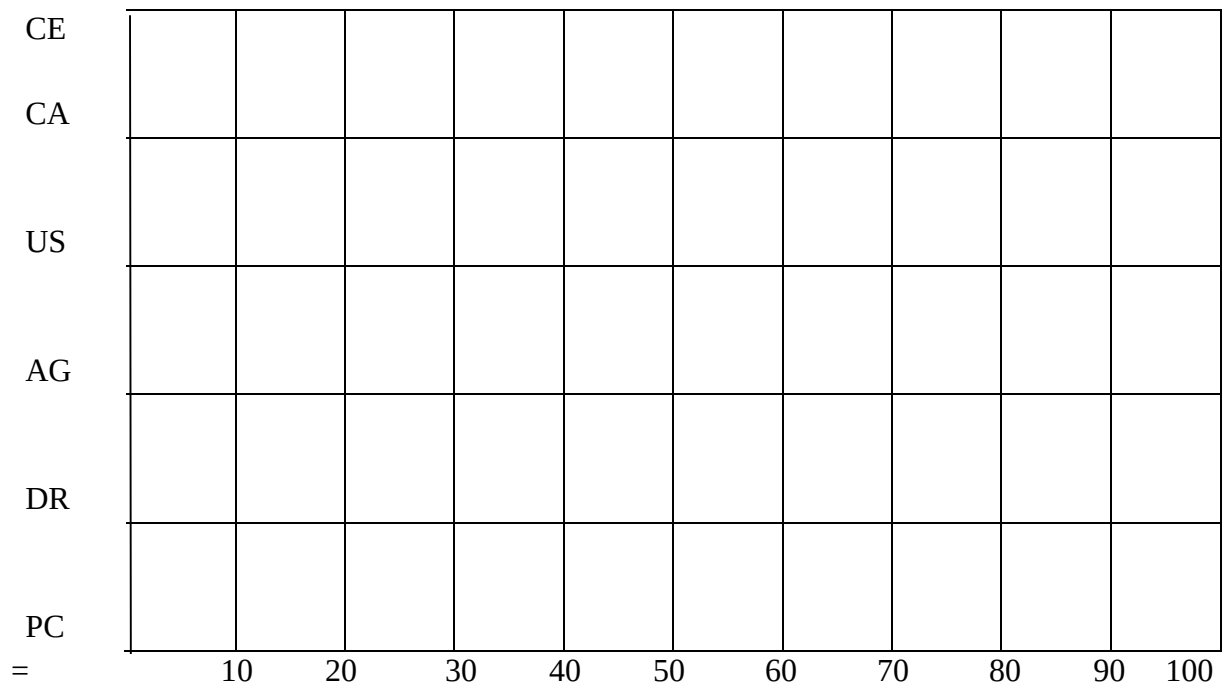


DIAGRAMME DE COUVERTURE

VI. ANALYSE DES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE GOULOTS D'ÉTRANGLEMENT, LES CAUSES ET LES STRATÉGIES DE RÉOLUTION.

6.1 Analyse du goulot d'étranglement :

Dire que le goulot d'étranglement est situé par exemple entre l'AG et l'US est une analyse de ce goulots.

Tableau n°1 : Etude des principaux goulots d'étranglements dans le monitoring des activites au niveau d'un établissement sanitaire de premier contact (Analyse, Causes probables, Stratégies potentielles, Personne ou Structure chargée de la mise en œuvre des stratégies)

Site du goulot d'étranglement	Analyse du goulot	Causes Probables	Stratégies	Personne ou structure pour exécuter les stratégies
Entre la CA et la CE	La population reçoit les soins en quantité et non en qualité	Non maîtrise des techniques de soins par les agents de santé Méconnaissance des normes exigées pour la qualité des soins Absence ou insuffisance de supervision	Formation de l'IDE/SF sur les techniques des soins indiqués Formation de l'IDE/SF sur les normes exigées pour la qualité des soins Organisation ou intensification des supervisions	SUS DD district Le chargé de la formation continue -ONG -ECD -Direction Régionale -Direction Centrale -Partenaires
Entre l'US et la CA	La population vient une fois recevoir un soin, mais ne revient plus pour terminer la série de soins souhaitée pour avoir l'effet escompté.	Mauvais accueil des patients Rendez-vous non mentionné dans le document de soins et non expliqué Attente trop longue pour les patients Apparition des MAPI	Renforcement de capacité de l'IDE/SF sur l'accueil Mention et explication des dates des RDV Réduction du temps d'attente par une bonne organisation du service Respect rigoureux de l'asepsie pendant les soins	ONG ECD Direction Régionale Direction Centrale Partenaires extérieurs
Entre l'AG et l'US	La population a accès au service, mais ne le fréquente pas	Manque ou insuffisance d'informations de la population sur les activités du centre de santé	Information de la population sur les activités du centre (utilisation des moyens locaux d'informations)	Agents de santé (infirmier Sage-femme) Coges

		-Considérations socioculturelles	Sensibilisation de la population sur l'importance de fréquenter les services de santé en cas de besoin tout en respectant leurs coutumes	
Entre la DR et l'AG	Ressource disponible, mais la population n'y a pas accès parce qu'elle se trouve à + de 5 km ou + de 10 km pour les CSC	Inaccessibilité géographique de la population Inexistence ou non fonctionnement des cases de santé	Organisation des stratégies avancées Ouverture ou redynamisation des cases de santé et formation des relais communautaires	Infirmier (formation) -Sage-femme (formation) -Coges (choix des ASC)
Entre la PC et la DR	Population cible présente, mais manque ou insuffisance de ressources (médicaments, vaccins etc.)	Rupture des ressources (vaccins, etc.) Intervalle de commande trop long Mauvaise estimation des besoins en ressources Mauvaise estimation du dénominateur	Approvisionnement en ressources (Vaccins, etc.) Réduction de l'intervalle de commande à un mois Formation du personnel de santé sur l'estimation des besoins en ressources concernées Formation du personnel de santé sur le calcul du dénominateur	-Infirmier -Sage-femme -Coges -Médecin chef du district Sanitaire

BUDGETISATION DES RESSOURCES PROPRES D'UN ESPC DANS LE CADRE DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES

Objectif général

Ce cours vise à permettre à l'étudiant IDE/SF/M de la L2 de comprendre le processus d'élaboration du budget d'un ESPC à partir des ressources propres dans le cadre des interventions des SSP

Objectifs spécifiques

A la fin du cours, il doit être capable de :

- 1) Définir le terme suivants :ressources brutes, ressources propres, budget
- 2) Enumérer les deux composantes d'un budget .
- 3) Enumerer trois caractéristiques du budget d'un ESPC ;
- 4) Expliquer les quatre rubriques du budget d'un ESPC.
- 5) Définir le terme reserve supplementaire

INTRODUCTION

Une bonne gestion financière est celle qui établit un ordre de priorité au niveau des dépenses. Les activités de gestion des SSP recommandent que les ressources financières issues du recouvrement des coûts des actes de santé soient budgétisées avant d'être dépensées. IL est donc important que l'infirmier et la sage femmes, responsable des structures sanitaires périphériques rurales connaissent le mécanisme de l'élaboration du budget

I.DÉFINITIONS DES TERMES

1.1 Recette brute (RB)

C'est la somme totale recouvrée par l'infirmier et les sages-femmes au cours d'une période donnée à partir des actes de santé (consultation de soins, accouchement, pansements, injections petites chirurgies, etc.) et de la vente des carnets de santé

1.2 Ressource propres (RP)

C'est la somme totale disponible du centre au cours d'une période donnée après les différentes dépenses du centre. Elle est aussi appelée somme à budgétiser ou recette des 6 mois couverts par le monitoring.

Les différences du centre de santé sont :

✓ ***Le Fonds d'Aide Social (FAS) :***

C'est une sorte d'impôt prélevé sur les recettes. Il correspond à 10% des recettes brutes. Il doit être déposé chaque mois au bureau du district sanitaire.

✓ ***L'Interessement du Personnel (IP):***

C'est une motivation que le comité de gestion verse à l'infirmier et la sage-femme pour ses activités au sein du Coges. Il correspond à 15% des recettes brutes. Il doit être réparti équitablement entre les deux.

✓ ***Le Salaire du personnel de Soutien (SPS)***

C'est la paie du personnel d'aide et de soutien recruté par le Coges à la demande de l'infirmier ou la sage-femme pour des activités spécifiques. Il correspond à 20% des recettes brutes.

✓ **Formule**

$\text{Ressource propre} = \text{Recettes Brutes} - \text{Total de dépenses du centre (FAS-IP-SPS)}$
--

NB : C'est le total des ressources propres déposées sur le compte bancaire du centre par le trésorier du Coges qu'on appellera plus tard somme à la banque à la veille du monitoring.

1.3 Budget

Dans le cadre de la gestion des activités des SSP, le budget est l'expression chiffrée des activités des structures sanitaires au niveau rural (centre de santé rural, dispensaire rural et maternité rurale) au cours d'une période donnée.

II. LES COMPOSANTES DU BUDGET.

Le budget des structures rurales se compose de deux parties :

2.1 L'investissement

- Achat des équipements du centre (mobylette et accessoires, réfrigérateur)
- Construction d'un hangar ou préau pour la vaccination par exemple.

2.2 Le fonctionnement

- Salaires du personnel non pris en charge par l'Etat ;
- Entretien courant des locaux, du matériel et du mobilier ;

- Fournitures techniques et administratives ;
- Consommation d'eau et d'électricité.).
- Bouteille de gaz pour les réfrigérateur à gaz pour les centres non électrifiés

III. CARACTERISTIQUES DU BUDGET D'UN ESPC DU NIVEAU RURAL.

- Le budget est élaboré tous les six mois en Côte d'Ivoire. Il se fait dans la même période que le monitoring des activités. Il peut se faire aussi annuellement
- Le budget n'est pas prévisionnel. Il est disponible car il représente les recettes des six mois correspondant à la période du monitoring.
- Le budget est la répartition des dépenses à partir de la somme recueillie pendant les 6 mois correspondant à la période du monitoring ;
- Le budget couvre les dépenses de la structure sanitaire rurale pour les 6 prochains mois à partir de la période du monitoring.

IV. LES RUBRIQUES ENTRANT DANS L'ÉLABORATION DU BUDGET D'UN ESPC DANS LE CADRE DES SSP SONT

- Le fonds de réserve (FR) ;
- La somme à budgétiser (SAB) ;
- Les dépenses obligatoires (DO) ;
- Les dépenses de fonctionnement locales (DFL) ;

4.1 Fonds de réserve (FR)

Le fond de réserve du centre correspond à la somme réellement à la banque à la veille du monitoring. Le calcul du fonds de réserve doit tenir compte des mouvements sur le compte à savoir les intérêts et les agios.

Le fonds de réserve est le solde du centre à la date du monitoring non compris les recettes des six mois correspondant à la période du monitoring si celle-ci ont été versées sur le compte.

Le Fonds de réserve se calcule en soustrayant de la somme à la banque à la date du monitoring, les recettes des six mois correspondant à la période du monitoring si celles-ci ont été déposées sur le compte.

✓ *Formule*

FR= Somme à la banque à la veille du monitoring – Recettes des six mois correspondant à la période du monitoring si elles sont déposées sur le compte.

4.2 La somme à budgétiser (SAB)

C'est le total des recettes des six mois correspondant à la période du monitoring. Elle se compose de deux éparties :

4.2.1 Les recettes issues de la vente des médicaments essentiels (RVME). Elles correspondent au total des recettes de la vente des médicaments essentiels effectivement versées à la nouvelle pharmacie de la santé publique (PSP) du district sanitaire.

Signalons dans le calcul des RVME, les depots non justifiés par des reçus de versements ne sont pas pris en compte.

4.2.2 Les recettes du comité de gestion ou recettes du coût des actes de santé

C'est la somme issue du coût des actes de santé (consultation, vente de carnets, etc.)

Elle se calcule en additionnant les recettes issues de la vente des médicaments essentiels (RVME) et les recettes issues du coût des actes de santé (RCAS).

✓ *Formule*

SAB= Recettes issues de la vente des médicaments essentielles + Recettes issues du coûts des actes de santé

4.3 Les dépenses obligatoires (ou dépenses incompressibles)

Ce sont les dépenses qui sont indispensables au bon fonctionnement du centre, c'est à dire des dépenses sans lesquelles le centre ne peut fonctionner.

Elles se composent de trois éléments :

- la disponibilité en médicaments essentiels (médicaments génériques) ;
- la disponibilité en outils de gestions (les différents registres);
- la disponibilité des activités de vaccination (caburant pour stratégie avancé, paiement des factures de l'électricité, etc.)

✓ *Formule*

Dépense obligatoire = Somme à budgétiser – Dépenses de Fonctionnement local

4.4 Les dépenses de fonctionnement local.

Elles sont moins indispensables que les dépenses obligatoires et regroupent les chapitres suivants :

- Matériel et fourniture de bureau pour fonctionnement (stylos, cahier, etc.);
- Matériel d'entretien (savon, balai, râtelier, pelle etc) ;
- Entretien du local (frais de désherbage de la cour du centre , vidange de la fosse septique, etc.) ;
- Emballage de petit matériel médical (sachets plastiques pour le conditionnement des médicaments par exemple) ;
- Entretien de la moto (frais de lubrifiant, frais de petites réparations, les pneumatiques etc.) ;
- Matériel divers (serrures, chaises ou tables, matelas, ampoules à changer etc.).
- **Immeuble** : frais de réparation éventuelle. Ils ne doivent pas excéder **10%** des fonds alloués à la rubrique des dépenses de fonctionnement local.
- **Imprévu** : frais bancaires, carburant pour les urgences. Ils ne doivent pas excéder **5%** des dépenses de fonctionnement local.

✓ *Formule*

$\text{Dépenses de fonctionnement local} = \text{Somme à budgétiser} - \text{Dépenses Obligatoires}$
--

V Réserve supplémentaire éventuelle :

C'est la somme qui pourrait éventuellement rester après les dépenses. Elle est généralement ajoutée sur le fonds de réserve. Elle pourrait aussi servir à intéresser les membres communautaires du Coges à travers un système mis en place au cours du programme

CONCLUSION

La budgétisation des ressources propres d'un ESPC est une activité de gestion dans le cadre des activités des Soins de Santé Primaires. Elle permet à l'agent de santé de suivre les recettes et les dépenses du centre de santé, d'accroître l'efficacité dans le fonctionnement du centre par la priorisation dans le financement des activités.

Les agents de santé doivent effectuer cette activité si nous voulons pérenniser le financement de nos structures sanitaires.

.ORGANISATION DE LA REFERENCE/CONTRE REFERENCE

Objectif général

Ce cours vise à permettre à l'étudiant IDE/SF/M de la L3 d'organiser un système de référence et de contre référence au niveau de l'ESPC

Objectifs spécifiques

A la fin du cours, il doit être capable de :

- 1) Définir la référence et la contre référence
- 2) Enoncer le but de la référence contre référence
- 3) Décrire l'organisation de la référence et de la contre référence au niveau de l'ESPC
- 4) Décrire le rôle de l'infirmier et de la sage-femme dans le système de référence et contre référence au niveau de l'ESPC

I. DEFINITIONS

1.1 Référence

Selon l'UNICEF, la référence est le fait que le prestataire de soins de l'Etablissement Sanitaire de Premier Contact (ESPC) amène le malade dans un établissement sanitaire de premier recours dit de référence parce que l'état de santé de celui-ci nécessite un plateau technique non disponible au niveau de l'ESPC.

1.2 Contre référence

Elle se définit comme le retour du patient dans l'établissement sanitaire de premier contact ou d'origine pour la poursuite de son traitement.

II. BUT DE LA RÉFÉRENCE/CONTRE RÉFÉRENCE

Assurer la prise en charge la plus adéquate du malade en vue de lui offrir des soins les plus adaptés et les plus qualifiés.

II. ORGANISATION DE LA RÉFÉRENCE /CONTRE RÉFÉRENCE

3.1 Au niveau de l'établissement sanitaire de premier contact (ESPC)

✓ *La référence*

Pour décider de la référence, le prestataire de soins :

- Se sert de l'ordinogramme pour décider de la référence
- Informe et convainc le malade ou ses accompagnants de la nécessité de la référence ;
- Remplit la fiche de référence tout en mentionnant le caractère **urgent ou non** de la référence ;
- Remet au malade ou aux accompagnants la fiche de référence avec des consignes
- Inscrit dans la colonne conduite à tenir du registre de consultation, la date et l'heure de la référence ;
- Averti en cas de référence urgente, le service d'accueil (téléphone...).

.2 Au niveau de l'établissement sanitaire de référence

✓ *La contre référence*

- Elle est faite si le malade doit retourner dans son centre de santé d'origine pour poursuivre son traitement. Dans ce cas, le médecin chargé des malades référés remplit la partie contre référence de la fiche, la détache et la remet au malade ou à ses accompagnants
- Il rassure le malade sur la prise en charge et sa probable guérison et lui demande de retourner dans son centre d'origine pour poursuivre le traitement.
- Au retour du malade dans le centre d'origine, le prestataire de soins de l'ESPC se base sur les informations mentionnées sur la fiche de la contre référence pour continuer les soins ;
- Il remplit le dossier de synthèse du malade à l'aide des informations de la fiche de la contre référence.
- Si l'état de santé du malade requiert un plateau technique plus élevé (CHR ou CHU), un autre système de référence est organisé au niveau de l'hôpital

IV. Facteurs à prendre en compte en cas de référence

La référence est une urgence qu'il faille très vite organiser. Quelques facteurs qui pourraient perturber sa bonne organisation sont à prendre en compte. Il s'agit :

- Du temps à mettre pour atteindre le centre de référence qui est dépend souvent de l'état de la route ;
- De l'environnement socioculturel du malade. (Exemple : Des malades référés pourraient refuser de partir pour des raisons d'ordre culturel).
- De la capacité financière du malade ou de ses accompagnants pour faire face aux dépenses imprévues occasionnées par la référence etc.

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE DE GESTION D'UN ESPC

Objectif général

Ce cours vise à permettre à l'étudiant IDE/SF/M de la L3 de maîtriser l'organisation et le fonctionnement du comité de gestion (Coges) d'un ESPC dans le cadre des interventions des Soins de Santé Primaires.

Objectifs spécifiques

Au terme de l'enseignement, il doit être capable de :

- 1) Définir le « terme comité de gestion »
- 2) Enoncer le but du comité de gestion
- 3) Enoncer la composition du Coges tout en précisant sa durée et les critères d'appartenance.
- 4) Enumérer les rôles du Coges dans le centre et en dehors du centre.
- 5) Citez tous les outils de gestion du Coges.
- 6) Enumérer les sources de revenu du Coges ainsi que les domaines des dépenses.
- 7) Enumérer les fonctions des membres du bureau du Coges.
- 8) Indiquer les niveaux d'implication des membres communautaires au sein du Coges

INTRODUCTION

Les Soins de Santé Primaires (SSP) mettent l'accent dans leur mise en œuvre sur la participation active des populations bénéficiaires. Ainsi, la création des comités de gestion et l'activation des fonctions des relais communautaires (ASC et AT) répondent à la nécessité d'associer la population à la gestion du centre pour que celle-ci soit adaptée à leurs préoccupations réelles.

I. DÉFINITION DU COMITÉ DE GESTION

Le comité de gestion se définit comme un groupe de personnes choisies par les membres de la communauté et qui participent au côté des agents de santé à la conduite des activités de gestion et de fonctionnement des formations sanitaires rurales.

Les règles de gestion des formations sanitaires rurales sont fixées par le décret N° 93-218 du 03 février 1993.

II-BUT DE LA CRÉATION DU COGES

La création du Coges répond à la nécessité d'associer la communauté comme membres actifs aux activités de gestion et de fonctionnement du centre de santé.

III-COMPOSITION DU COMITÉ DE GESTION

Le décret n° 93-218 du 03 février 1993, à son article 3 stipule que le comité de gestion doit être composé de 10 à 20 personnes représentantes des communautés villageoises de l'aire sanitaire. Outre l'infirmier, la sage-femme ou le travailleur social, les autres membres sont issus de la communauté.

Le bureau du Coges comprend :

- 01Président (membre communautaire) ;
- 01Responsable de la gestion financière (membre communautaire);
- 01Responsable de la gestion administrative et technique (l'infirmier, la sage-femme ou le travailleur social).

Nota Bene

- Les ASC et AT font partis d'office du Coges à cause de leur rôle de relais communautaire.
- Il est recommandé que chaque village desservi par le centre de santé ait un représentant dans le Coges.
- La participation aux activités du Coges est du bénévolat.

IV DURÉE DU MANDAT DES MEMBRES DU COGES

Le décret suscité stipule à son article 3 que les membres du comité de gestion sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable.

V. CRITÈRES POUR ÊTRE MEMBRE DU COGES D'UN CENTRE DE SANTE

Pour être membre du Coges, il faut remplir les conditions suivantes :

- Résider en permanence dans un village desservi par le centre de santé ;
- Ne pas avoir commis de délit public ou être de bonne moralité
- Avoir une activité génératrice de revenu.

VI. FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE GESTION

6.1 Rôles du comité de gestion dans le centre

6.1.1 Rôles dans la gestion financière. Le Coges

- Décide du montant de la participation financière des communautés villageoises (ce montant ne doit pas excéder celui prévu par la tarification nationale) ;
- Décide des dépenses de fonctionnement supportées par la participation financière des usagers (entretien du centre de santé, paiement des factures d'eau et d'électricité...) ;
- Élabore le budget semestriel ;
- Suit le mouvement de l'argent à la banque ;
- Est chargé d'ouvrir un compte bancaire au nom du comité dans un établissement bancaire de la place avec les signatures conjointes du représentant de l'administration (Responsable de la gestion administrative et technique), du président et du responsable de la gestion financière.

6.1.2 Rôles dans la gestion des ressources humaines

Le comité de gestion doit veiller :

- À la présence du personnel de santé et de soutien ;
- À la qualité de la communication entre les consultants et le personnel ;
- Au savoir être du personnel de santé.

6.1.3 Rôles dans la gestion du matériel, des médicaments et du local

Le comité de gestion doit veiller :

- À la disponibilité des médicaments essentiels et des vaccins ;
- À la propreté du centre de santé ;
- Au suivi de la bonne gestion des stocks de matériel alloués à la structure sanitaire pour son bon fonctionnement ;
- À l'éclairage du centre de santé et à son approvisionnement en eau potable ;
- À la propreté des locaux et du matériel ;
- À l'entretien des locaux et du matériel.

6. 2 Rôle du comité de gestion en dehors du centre

Le comité de gestion doit :

- Faire connaître aux populations les activités menées au centre de santé ;
- Promouvoir la participation financière de la population ;
- Promouvoir l'acceptabilité des services offerts à la population ;
- Encourager les changements de comportements observés au niveau des différents acteurs et utilisateurs (personnel de santé et population.)

VII. LES OUTILS DE GESTION DES RESPONSABLES DU COMITÉ DE GESTION

7-1 Le responsable de la gestion administrative et technique

- Les registres du système d'informations et de gestions (accouchement, consultation de soins curatifs, Consultation Prénatale, vaccination, etc.) ;
- Le cahier de versement journalier des recettes du centre ;
- Les reçus des sommes confiées au responsable de la gestion financière ;
- Le plan d'action du centre de santé ;
- Le cahier des comptes rendus des différentes réunions du Coges.

7-2. Le responsable de la gestion financière :

- Le livret d'épargne ou tout autre document bancaire ;
- Le livret de caisse pour noter les recettes et les dépenses du centre ;
- Le carnet de souches des reçus des fonds confiés par le responsable de la gestion administrative et technique ;
- Les justificatifs des fonds déposés dans le compte ;
- Les justificatifs des dépenses effectuées ;
- Le budget de fonctionnement assuré par l'autofinancement.

VIII. LES FONCTION DES MEMBRES DU BUREAU DU COGES

8.1 Le président : Il est chargé :

- D'ouvrir un compte au nom du centre de santé dans un établissement bancaire public ou privé de la place ;
- De convoquer les réunions en accord avec le responsable de la gestion administrative. Il dirige les débats pour parvenir à un consensus ;
- De donner son accord pour les retraits de l'argent à la banque ;
- De coordonner les activités du Coges ;

- D'organiser les contrôles périodiques de la gestion financière avec l'équipe cadre du district sanitaire et rendre compte aux autres membres du comité.

8.2 Le responsable de la gestion financière

Il travaille en étroite collaboration avec les agents de santé. Il est chargé :

- De recueillir à la fin de chaque journée de travail, les sommes d'argent collectées par le personnel de santé ;
- D'enregistrer les recettes du centre de santé dans le livret de caisse ;
- De verser les recettes du centre de santé à la banque et garder les reçus pour tout contrôle éventuel ;
- De faire, à la fin de chaque mois, le cumul des sommes versées à la banque ainsi que celui des dépenses effectuées ;
- D'établir le bilan de la gestion financière du centre de santé, de donner une copie au président et déposer une autre copie au district sanitaire ;
- De participer aux activités de supervision avec les autres membres du comité gestion ;
- D'effectuer les dépenses du Coges avec l'accord du président et du Directeur Départemental de la Santé

8.3 Le responsable de la gestion administrative et technique

En plus de son rôle de prestataire de soins, il est chargé :

- D'encaisser quotidiennement les sommes issues du coût des actes de santé.
- de verser de façon journalière ou selon le rythme de versement consensuel, les fonds collectés au responsable de la gestion financière;
- D'assurer les tâches du secrétariat du Coges ;
- De convoquer les réunions du comité de gestion en accord avec le président et rédige les procès-verbaux ;
- d'établir avec le comité de gestion, les priorités d'investissement et de fonctionnement en tenant compte des problèmes sanitaires prioritaires de la localité et des activités planifiées ;
- d'élaborer en accord avec le comité de gestion, le budget du centre de santé à partir des ressources propres.

IX. LES SOURCES DE REVENUS ET LES DOMAINES DE DÉPENSES DU COGES

9-1 Sources de revenus

- Les actes de santé (frais de consultations, de pansement, de petite chirurgie, de mise en observation, etc.) ;
- La vente de certains documents (carnet de santé mère/enfant, carnet de santé, carte de vaccination, etc.) ;
- Les dons et legs.

9-2 Domaines de dépenses

L'article 7 du décret N° 93-218 du 03 février 1993 précise les dépenses des comités de gestion des formations sanitaires rurales. Elles sont obligatoires et sont liées :

- aux salaires du personnel non pris en charge par l'Etat ;
- à l'entretien courant des locaux, du matériel et du mobilier ;
- aux fournitures techniques et administratives ;
- à la consommation d'eau et d'électricité.

10. NIVEAUX D'IMPLICATION DE LA COMMUNAUTE DANS LES ACTIVITES DU COGES

L'implication de la communauté dans les activités du Coges se situe au niveau de sa participation :

- aux avantages des programmes (bénéficiaire) ;
- aux activités des programmes (main-d'œuvre) ;
- à l'exécution des programmes (case de santé, etc.) ;
- à la surveillance et à l'évaluation des programmes (monitorage, supervision) ;
- à la gestion des programmes (gestion financière des coûts des actes de santé) ;
- à la planification et à la détermination des programmes (analyse de la situation, choix des priorités).

CONCLUSION

La mise en œuvre des activités du Paquet Minimum d'Activités des ESPC ne peut être effective qu'avec la participation effective de la communauté villageoise. Il est donc important qu'elle soit associée) la prise de décision concernant la gestion et le fonctionnement des structures sanitaires

GESTION DE L'INFORMATION SANITAIRE

Objectif général

Ce cours vise à permettre à l'étudiant IDE/SF/M de la L3 de gérer de façon efficace et efficiente données sanitaires produites dans sa zone de desserte.

Objectifs spécifiques

Au terme de l'enseignement, il doit être capable de :

- 1) Définir les concepts liés à la gestion de l'information sanitaire
- 2) Enoncer toutes les étapes du processus de génération de l'information sanitaire ;
- 3) Décrire le rôle des différents acteurs impliqués dans la gestion de l'information sanitaire conformément à leurs niveaux respectifs de gestion ;
- 4) Décrire le circuit de l'information sanitaire ;
- 5) Enoncer les niveaux d'intervention du Système d'Information et de Gestion (SIG) Ivoirien
- 6) Décrire les outils de collecte de données sanitaires ;
- 7) Remplir correctement les outils de collecte des données sanitaires (TD)

INTRODUCTION

L'information sanitaire de qualité permet aux autorités sanitaires de prendre des décisions éclairées, soit pour redynamiser le système de santé, soit pour renforcer le système de soins en vue de répondre efficacement aux besoins des populations. L'infirmier et la sage-femme qui exercent dans les structures sanitaires de prestations (ESPC, Hôpital général, etc.) et de gestion (District sanitaire) sont les premiers responsables de la gestion des données sanitaires. Ils doivent donc connaître et s'approprier le mécanisme de gestion de ces données aux différents niveaux de notre système de santé, d'où l'intérêt du cours

I. DÉFINITIONS DES CONCEPTS LIÉS À LA GESTION DE L'INFORMATION SANITAIRE

1.1 Indicateur

C'est une variable quantitative ou qualitative simple qui mesure un aspect d'une intervention en santé, programme ou projet.

1.2 Donnée

Elle représente l'input (la matière première). Elle est considérée comme des ressources que l'on transforme en produits informatifs.

1.3 Information

L'information est le résultat de la transformation des données en faits utiles pour les décideurs. Elle représente les données placées dans un contexte significatif et utile pour l'utilisateur final.

1.4 Information sanitaire

C'est toute information qui se rapporte aux différentes composantes du système de santé à savoir les ressources humaines, financières, les structures de santé, les équipements, les activités et les clients.

1.5 Système d'information sanitaire

Selon l'Organisation mondiale de la santé, un système d'information sanitaire (SIS) est un « ensemble d'éléments et de procédures étroitement liés ayant pour but de fournir des renseignements et des informations sanitaires permettant de surveiller l'état et les services de santé d'un pays, afin d'améliorer l'administration et les décisions concernant la gestion des soins de santé publique à tous les niveaux ».

1.6 Gestion de l'information sanitaire

C'est l'ensemble des opérations qui consiste à enregistrer les données sanitaires dans les registres d'activités, à les stocker sur les fiches de rapports, à les transmettre aux différents niveaux concernés de la pyramide sanitaire, à les traiter pour produire une information utilisable, à analyser, à interpréter l'information produite et à l'utiliser.

II. LES ÉTAPES DU PROCESSUS DE GÉNÉRATION DE L'INFORMATION SANITAIRE

Une fois les besoins d'informations définis, un processus de génération d'information bien structuré peut optimiser l'utilité des données à la prise de décisions aux différents niveaux.

2.1 La collecte des données sanitaires

C'est l'acte qui consiste à enregistrer toutes les données sanitaires dans les registres d'activités puis les reporter ou les compiler dans les fiches de rapport mensuel ou annuel.

2.2 La compilation des données sanitaires

Elle consiste à reporter à la fin de chaque mois d'activités, sur des graphiques simples, les données brutes se rapportant à un certain nombre d'éléments, notamment :

- Le nombre de consultants et de consultations ;
- Le nombre de doses de vaccins BCG, DTCHepBHib3, PCV13-3, Rotarix 2administrées ;

2.3 La transmission des données sanitaires

C'est l'opération qui consiste pour chaque niveau de la pyramide sanitaire à acheminer selon un délai bien défini, les fiches de rapports mensuels ou annuels d'activités au niveau supérieur immédiat (voir tableau ci-dessous).

Sigle	Type de rapport et structure sanitaire de provenance	Date limite d'envoi
A	Rapport mensuel de l'établissement sanitaire de premier contact avec laboratoire et/ou cabinet dentaire fonctionnel, menant des activités de lutte contre la lèpre et la tuberculose	Le 5 du mois suivant
A3	Rapport annuel de l'établissement sanitaire de premier contact	Le 30 janvier de l'année suivante
B1	Rapport mensuel de l'Hôpital Général	Le 10 du mois suivant
B2	Rapport annuel de l'Hôpital Général	Le 30 janvier de l'année suivante
C1	Rapport mensuel du Centre Hospitalier Régional	Le 15 du mois suivant
C2	Rapport annuel du Centre Hospitalier Régional	Le 30 janvier de l'année suivante
D1	Rapport trimestriel de la Direction Départementale de la Santé et de l'Hygiène publique	Le 10 du trimestre suivant
E1	Rapport trimestriel de la Direction Régionale de la santé et de l'Hygiène publique	Le 10 du 1 ^{er} mois du trimestre suivant

2.3.1 Promptitude des rapports

C'est le fait que les données sanitaires doivent être reçues par les services destinataires au plus tard à la date limite fixée. Elle est aussi considérée comme le nombre de rapports reçus par le service destinataire dans le délai requis.

Dans les ESPC, le rapport mensuel d'activités doit être transmis au responsable du CSE du district sanitaire au plus tard le 5 du mois suivant.

❖ **Calcul du taux de promptitude**

Il se calcule en divisant le nombre de rapports mensuels d'activités reçus par le responsable du CSE dans le délai requis par le nombre de rapports d'activités attendus.

✓ **Formule**

$$TP = \frac{\text{Nombre de rapports mensuels d'activités reçus dans le délai requis}}{\text{Nombre de rapports d'activités attendus}} \times 100$$

2.3.2 Complétude des rapports

Elle consiste en l'envoi de tous les rapports d'activités des structures de santé au service destinataire qui doit les recevoir. Ainsi, à la fin de chaque mois, les responsables des ESPC doivent faire parvenir leur rapport d'activité au district sanitaire

❖ **Calcul du taux de complétude**

Il se calcule en divisant le nombre de rapports d'activités reçus par le responsable du CSE par le nombre de rapports d'activités attendus.

✓ **Formule**

$$TC = \frac{\text{Nombre de rapports d'activités reçus par le responsable du CSE}}{\text{Nombre de rapports d'activités attendus}} \times 100$$

Remarque : *Un mauvais taux de promptitude n'augure pas forcément d'un mauvais taux de complétude. En effet, le taux de promptitude est d'autant plus important que les services envoient les rapports dans les délais requis. Quant au taux de complétude, il est simplement bon pourvu que les rapports soient transmis ; peu importe les délais de transmission.*

2.4 Le traitement des données sanitaires

C'est l'utilisation de l'ordinateur ou de tout autre moyen technique pour transformer les données brutes collectées en faits utiles pour les prises de décision.

2.5 L'Analyse et l'interprétation des données sanitaires

C'est un jugement de valeur porté sur les données collectées du point de vue de leur validité et des tendances qu'elles pourraient faire ressortir.

2.6 L'utilisation de l'information sanitaire

C'est l'acte qui consiste à prendre des décisions ou à mener des actions à partir de l'information sanitaire produite.

L'action à entreprendre dépendra des causes du problème décelé et du niveau des structures sanitaires. Le personnel de santé des ESPC et de l'équipe cadre du district peuvent prendre des décisions au niveau local. Il est donc important pour ce personnel de déterminer les solutions envisageables pour chaque problème identifié au cours de l'analyse et de l'interprétation de l'information sanitaire.

L'information sanitaire est aussi utilisée pour le monitoring des activités des structures de santé. Il s'agit notamment :

- De mener des réflexions sur l'évolution des activités, l'état de santé de la population ;
- D'identifier et d'analyser les causes des écarts entre ce qui est par rapport à ce qui était attendu ;
- De planifier les activités dans le cadre de la modification ou prendre des mesures immédiates pour améliorer la situation ;
- D'assurer la surveillance épidémiologique (système de collecte, d'analyse et d'interprétation des données sur les maladies).

.7 La diffusion de l'information.

C'est la communication des informations aux personnes chargées de prendre des décisions. Elles peuvent être :

- Les décideurs du niveau central (Ministère) ;
- Les administrateurs et le personnel de santé des programmes de santé peuvent exploiter les informations pour mener leurs interventions sur le terrain ;
- Les partenaires au développement (OMS, UNICEF, etc.) ;
- Les dirigeants des communautés pour des actions communautaires (Diagnostic communautaire) ;

- Le personnel des organismes intervenant dans le secteur de la santé et les organisations non gouvernementales pour leurs activités au niveau national et au niveau du district.

2.8 La rétro information

C'est le retour de l'information produite vers les structures de prestation et de gestion des niveaux primaires et secondaires, productrices des données sanitaires.

III RÔLES DES DIFFÉRENTS ACTEURS IMPLIQUÉS DANS LA GESTION DE L'INFORMATION SANITAIRE AUX DIFFÉRENTS NIVEAUX DE LA PYRAMIDE SANITAIRE

L'information sanitaire est gérée par le personnel de santé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire nationale.

3.1 Au niveau périphérique

Ce niveau comprend les structures de prestations (centres de santé ruraux, urbains, hôpitaux généraux) et la structure de gestion (district sanitaire)

3.1.1 Au niveau des structures de prestations

Le personnel de santé (**infirmiers et sages-femmes**) doit :

- Enregistrer correctement toutes les informations sanitaires dans les différents registres de consultation curative et des activités préventives.
- Remplir correctement les fiches de rapports mensuels et annuels du système d'information et de gestion (SIG) en double exemplaire ;
- Acheminer les fiches de rapport mensuel au plus tard :
 - Le 5 du mois suivant au centre de surveillance épidémiologique du district sanitaire pour les établissements sanitaires de premier contact
 - Le 10 du mois suivant pour l'hôpital général ou Hôpital de référence
- Garder une copie de tous les rapports acheminés au district sanitaire dans leurs archives ;
- Réaliser des tableaux et graphiques simples des données et les afficher dans l'établissement sanitaire ;
- Analyser ces tableaux et graphiques pour mieux suivre localement l'évolution des activités menées ;
- Concevoir et afficher la cartographie de leur aire de santé ;

- Utiliser les données pour la planification opérationnelle.

3.1.2 Au niveau de la structure de gestion

Le responsable du centre de surveillance épidémiologique (CSE) a pour rôles :

- De collecter toutes les données des établissements sanitaires du district sanitaire ;
- De réceptionner les rapports hebdomadaires des établissements sanitaires de premier contact et de l'hôpital de référence;
- De compiler tous les rapports mensuels des établissements sanitaires de premier contact et de l'hôpital de référence ;
- D'établir le rapport hebdomadaire du district sanitaire ;
- De remplir le tableau de bord hebdomadaire des maladies à potentiel épidémique ;
- De participer aux supervisions des agents de santé des ESPC ;
- De transmettre au plus tard le 10 du mois suivant à la direction régionale sous supports magnétiques (disquette, CD.ROM ou autre disque amovible...) par tout moyen en sa possession, le rapport du district sanitaire
- D'analyser les données recueillies avec des courbes de tendance ;
- De faire la rétro information au niveau des ESPC et de l'hôpital général ;
- De notifier les données et les flambées suspectées/confirmées au niveau central ;
- De tenir correctement les rapports mensuels et annuels (archivage en fonction des mois et des années et par structure de prestation);
- D'acheminer le point épidémiologique sur support magnétique au centre de surveillance épidémiologique (CSE) de la région sanitaire par tout moyen en sa possession ;
- De réaliser les enquêtes épidémiologiques en cas d'épidémie ;
- D'expédier les prélèvements au niveau central pour les cas suspects des maladies à potentiel épidémique ;
- De tracer les courbes épidémiques ;
- De concevoir un bulletin départemental d'informations sanitaires ;
- De concevoir et afficher la cartographie du district sanitaire ;

3.3 Au niveau intermédiaire

Le responsable du CSE de la Direction Régionale de la Santé a pour rôles :

- De collecter toutes les données des districts de la région sanitaire ;
- De réceptionner les rapports hebdomadaires des districts sanitaires ;
- De compiler tous les rapports mensuels et annuels des districts sanitaires ;
- D'établir le rapport hebdomadaire de la région sanitaire ;
- Remplir le tableau de bord hebdomadaire des maladies à potentiel épidémique ;
- De participer aux supervisions des agents de santé des ESPC des districts sanitaires ;
- De transmettre au plus tard le 15 du mois suivant au niveau central le rapport de la direction régional par tout moyen en sa possession ;
- D'analyser les données recueillies avec des courbes de tendance ;
- De faire la rétro information aux districts sanitaires ;
- De notifier les données et les flambées suspectées/confirmées au niveau central ;
- De tenir correctement les rapports mensuels et annuels (archivage en fonction des mois et des années et par structure de prestation);
- D'acheminer le point épidémiologique par support magnétique au niveau central par tout moyen en sa possession ;
- De réaliser les enquêtes épidémiologiques en cas d'épidémie ;
- D'expédier les prélèvements dans les cas suspects des maladies à potentiel épidémique au niveau central ;
- De tracer les courbes épidémiques etc.

3.4. Au niveau central

Ici, la structure centrale qui s'occupe de la gestion des données sanitaires est la DIIS (Direction de l'Informatique et de l'Information sanitaire). Il est en général le niveau où sont établies les politiques en matière de surveillance des maladies infectieuses et/ou le plus souvent, les ressources sont attribuées. Le niveau central :

- Soutient les niveaux intermédiaires et périphériques ;
- Réagit de manière coordonnée aux flambées épidémiques d'ampleur nationale. il analyse les tendances générales des maladies et cible les ressources pour la lutte dans les zones à haut risque ;

- Assure la liaison avec les autres pays et les organismes internationaux lors de la riposte à ces flambées ;
- Entretien des relations avec les laboratoires nationaux de référence où l'identification de micro-organismes inhabituels doit déclencher une réaction.

IV. CIRCUIT DE L'INFORMATION SANITAIRE

Le circuit de l'information sanitaire se schématise de la manière suivante :

- Chaque responsable des formations sanitaires reporte tous les mois, les données de ses registres, dans le rapport d'activités correspondant à son plateau technique ;
- Le rapport d'activités, complètement renseigné, est transmis au Centre de Surveillance Epidémiologique (CSE) de la Direction Départementale de la Santé et de l'Hygiène Publique, au plus tard le 5 du mois suivant ;
- A ce niveau, le Responsable des CSE du district sanitaire valide les données et les saisit dans un ordinateur dans un délai de 14 jours ;
- Les données, compilées sur support informatique (disquette, CD.ROM ou autre disque amovible, etc.) sont ensuite adressées à la Direction Régionale de la Santé et de l'Hygiène Publique par le Directeur Départemental de la santé et de l'Hygiène Publique au plus tard le 15 du mois suivant ;
- La Direction Régionale de la Santé et de l'Hygiène Publique compile à son tour les données de l'ensemble des Districts sanitaires de la région sur support informatique (disquette, CD.ROM ou autre disque amovible...) et le transmet au niveau Central, à la Direction de l'Information Sanitaire (DIS) au plus tard le 21 du mois suivant ;
- La DIS, enfin traite l'information et la met à la disposition de tous les décideurs, les partenaires au développement du Ministère de la santé et de l'Hygiène Publique, notamment à travers le Rapport Annuel sur la Situation Sanitaire (RASS). Elle assure également un retour de l'information traitée (**retro information**) vers les Directions Régionales, les Districts Sanitaires et les structures de prestation.

Le schéma ci-dessous illustre le circuit de l'information sanitaire¹.

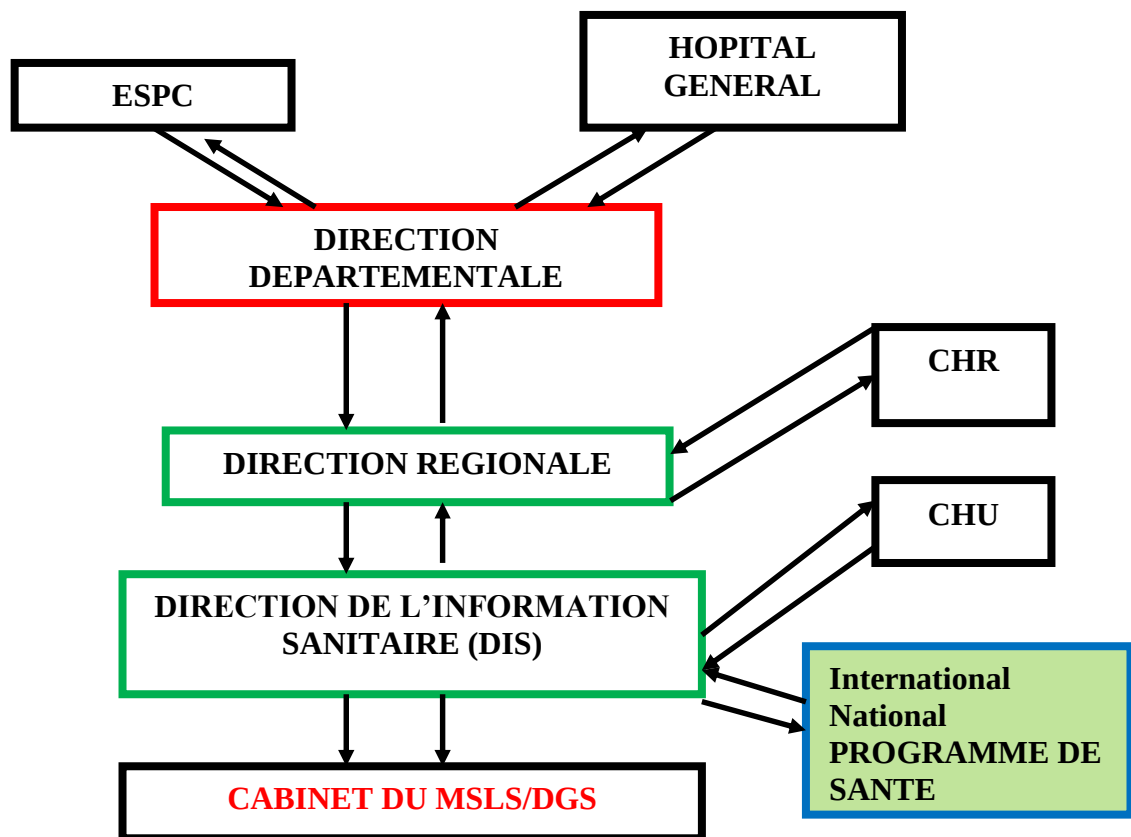


Figure n°1 : Schéma du circuit de l'information sanitaire

Source : Rapport d'évaluation du Système National d'Information Sanitaire Ivoirien par l'outil du réseau de métrologie sanitaire RMS / HMN

V. SYSTÈME D'INFORMATION ET DE GESTION

5.1 Définition

Le système d'information et de gestion est un outil de collecte continue de données des activités de santé et de gestion dans les établissements sanitaires de premier contact

5.2 Missions du SIG

Créé par arrêté ministériel N°28/MSP/DGSPS/DIEP, le Système d'Information et des gestions Ivoirien a pour principale mission de produire les indicateurs de suivi et d'évaluation de l'action sanitaire.

5.3 Objectifs du SIG

Le système d'information et de gestion a pour objectifs :

- De créer un environnement logiciel et matériel pour recueillir, stocker, traiter, restituer et communiquer l'information sanitaire pour faciliter la gestion, l'évaluation et la planification ;
- De créer une architecture de communications entre les différents échelons de la pyramide sanitaire par l'information et la rétro information et un système de gestion des données sur la santé publique ;
- De communiquer l'information fiable, nécessaire et à temps voulu aux soignants, gestionnaires, pouvoirs publics et autres intervenants dans le domaine de la santé pour l'aide à la décision;
- De normaliser la gestion des données de santé publique de façon à ce que les professionnels et les décideurs puissent avoir accès à des renseignements cruciaux en matière de santé publique et ce, au niveau local, régional et national ;
- D'obtenir une analyse descriptive périodique de la population en collectant des informations dans chaque service hospitalier et unité de soins ;
- De promouvoir des actions de recherche en mettant à la disposition des équipes de recherche des informations fiables, comparatives et complètes.

5.3 Niveau d'intervention du SIG de Côte d'Ivoire

Dans son fonctionnement, le SIG Ivoirien intervient à six niveaux que sont :

- Le niveau les Etablissements Sanitaires de premier contact (ESPC)
- Le niveau des Hôpitaux Généraux ou de référence ;
- Le niveau des Centres Hospitaliers Régionaux (CHR) ;
- Le niveau des Directions Départementales de la Santé et de l'Hygiène Publique ;
- Le niveau des Directions Régionales de la Santé et de l'Hygiène Publique ;
- Le niveau des Centres Hospitaliers et Universitaires (CHU) où le SIG n'est implanté que partiellement.

VI. Outils de collecte des données sanitaires

La fiabilité de l'information que l'on appelle aussi validité, est un préalable à toute analyse. Une information, qui manque de fiabilité, qui est imprécise et entachée d'erreurs au niveau d'un centre de santé, manquera aussi de la même fiabilité au niveau central.

Il faut donc veiller continuellement au cours des activités (consultations, vaccination, etc.), à enregistrer tous les patients et pour chaque patient, renseigner la totalité des rubriques demandées sur le registre.

- Les outils de collecte de données sont de quatre types :
- Les supports d'information individuelle ;
- Les registres ;
- Les fiches de rapport de morbidité quotidienne hebdomadaire ;
- Les fiches de rapports mensuels et annuels.

L'approvisionnement de tous ces outils de collecte d'information se fait au du district sanitaire.

5.1 Les supports d'information individuelle (dossiers, fiches cliniques)

Il existe différents types de supports d'information individuelle :

- Le carnet de santé ;
- La fiche de référence et de contre référence ;
- La fiche de planification familiale ;
- La fiche de CPN, etc. ;

5.2 Le registre

Le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique met à la disposition des formations sanitaires quatre différents types de registres. Les infirmiers et sages responsable de la collecte des données doivent choisir le registre selon la structure sanitaire (Fiche de rapport mensuel de type A pour les ESPC).

Parmi les différents registres utilisés dans les structures sanitaires, nous pouvons citer quelques-uns à savoir :

- Le registre de consultations générales pour les soins curatifs ;
- Le registre d'activités préventives pour la vaccination, la pesée et l'IEC/CCC ;
- Le registre de consultations pré et postnatales pour les femmes enceintes, etc.

✓ **Les fonctions du registre** : Le registre constitue :

- Un aide-mémoire du praticien ;
- Une pièce médico-légale ;
- Une base de données.

NB : *Il est impératif de bien remplir et bien conserver les registres*

5.3 Les fiches de rapport de morbidité quotidienne et hebdomadaire

Le rapport des maladies du registre de consultations générales peut se faire sur des fiches quotidiennes et hebdomadaires. Elles se remplissent par jour, par semaine ou par tranches d'âge (0-11 mois, 1-14 ans, 5-14 ans et 15 ans et plus).

L'avantage de ces fiches de rapport de morbidité quotidiennes et hebdomadaires est qu'elles réduisent les risques d'erreurs et font gagner du temps. Les différents types de fiches et leur périodicité de remplissage sont mentionnés dans le tableau ci-dessous :

Types de fiches intermédiaires	Période de remplissage
La fiche de comptage pour la CCC	Quotidienne
La fiche de comptage de l'accouchement	Quotidienne
La fiche de comptage des consultations pré et post-natales	Quotidienne
La fiche de comptage de la planification familiale	Quotidienne
La fiche de comptage de morbidité	Hebdomadaire
La fiche de comptage de la réhydratation	Quotidienne
La fiche de comptage du cabinet dentaire	Hebdomadaire

5.4 Les rapports mensuels et annuels

Après avoir collecté jour après jour les informations, il faut passer à reporter les informations collectées sur les fiches de rapports mensuels et annuels. Leur réalisation est simple lorsqu'on y attache beaucoup d'intérêt. Les informations qu'elles contiennent doivent absolument refléter la réalité. Pour cela, il faut les remplir correctement car ce sont des informations qui seront analysées et serviront de matériaux à la construction des indicateurs et au bout de la chaîne, au suivi et à l'évaluation de la politique nationale de santé. Ces rapports sont fonction de la position de la structure sanitaire dans la pyramide sanitaire. Ils sont au nombre de neuf et concernent :

- Les Etablissements Sanitaires de Premier Contact (A, A3) ;
- Les Hôpitaux Généraux ou de référence (B1, B2) ;
- Les Centres Hospitaliers Régionaux (C1, C2) ;
- Les Districts Sanitaires (D1) ;
- Les Directions Régionales de la Santé et de l'Hygiène Publique (E1).

Comme pour les registres, l'archivage des doubles des rapports mensuels et annuels est impératif. Il doit être soigneux, organisé et obéir à une classification chronologique (par an , par mois ou si possible par structure sanitaire).

Ces rapports sont des aide-mémoires des agents de santé des établissements sanitaires et constituent une base de données organisée, facilement utilisable.

Remarque :

Les rapports mensuels et annuels sont les premières bases de données organisées. Leur précision, fiabilité et propreté sont des atouts pour une analyse et une micro planification performante au niveau des établissements sanitaires de premier contact, mais aussi au niveau départemental, régional et national.

CONCLUSION

La nécessité d'une bonne gestion de l'information sanitaire est fondamentale dans les politiques de santé publique. Elle est gage de prise de décision au moment opportun pour rendre les structures sanitaires performantes. Cette performance est souvent compromise dès lors que le personnel de santé n'a pas l'expertise requise, pour gérer efficacement les données sanitaires produites.

GESTIONS DES CATASTROPHES NATURELLES/EPIDEMIES

Objectif général

Ce cours vise à permettre à l'étudiant IDE/SF/M de la L3 de gérer une catastrophe naturelle et épidémies dans sa zone sanitaire.

Objectifs spécifiques

A la fin du cours, il doit être capable de :

- 1) Définir sans erreur ainsi les termes liés à la catastrophe : danger, catastrophe, vulnérabilité et risque, gestion des catastrophes
- 2) Décrire les rôles de l'infirmier ou de la sage-femme dans la gestion des risques sanitaires en cas de catastrophe.

INTRODUCTION

Toutes les sociétés sont vulnérables aux catastrophes aussi bien naturelles que causées par l'homme. Toutes catastrophes quelles qu'en soit les causes, doivent être gérées de façon rapide, efficace et efficiente en vue de sauver des vies humaines et des biens matériels. Dans ces activités de gestion des catastrophes, l'infirmier et la sage-femme, ont un rôle important à jouer pour minimiser les risques sanitaires immédiats et potentiels des catastrophes.

I DÉFINITIONS DES TERMES LIÉS A LA GESTION DES CATASTROPHES.

1.1 Danger

C'est le potentiel d'un événement naturel ou causé par l'homme capable d'entraîner des conséquences négatives. Un danger peut devenir une situation d'urgence. Lorsque la situation d'urgence dépasse le contrôle de la population, il devient une catastrophe.

1.2 Catastrophe

C'est un événement naturel ou causé par l'homme qui a d'importants effets négatifs sur la population, les biens, services et/ou l'environnement, dépassant la capacité de la collectivité affectée à réagir.

1.4 Vulnérabilité

C'est le point auquel l'organisation d'une collectivité, d'un environnement et de services va probablement subir des dommages ou être perturbés par l'impact d'un danger.

1.5 Risque

C'est la probabilité selon laquelle il y aura des pertes en conséquence d'un événement défavorable, vu le danger et la vulnérabilité.

II. DÉFINITION DU TERME « GESTION DES CATASTROPHES »

La gestion des catastrophes est un processus systématique fondé sur les principes essentiels de gestion de la planification, l'organisation qui couvre la coordination et le contrôle. Elle vise à réduire l'effet négatif ou les conséquences d'événements indésirables contre lesquels l'homme ne peut pas maîtriser les effets néfastes.

III. DIFFÉRENCE ENTRE UNE SITUATION D'URGENCE ET UNE SITUATION DE CATASTROPHE

3.1 Situation d'urgence

Une situation d'urgence est une situation dans laquelle la société est capable de faire face à un événement indésirable.

3.2 Situation de catastrophe

Une situation de catastrophe est une situation où la société ne peut pas faire face à un événement indésirable.

IV DIFFÉRENTS TYPES DE CATASTROPHES NATURELLES

Les différentes catastrophes naturelles sont :

- Les cyclones ;
- Les tremblements de terre ;
- Le tsunami, etc.

V. CONSÉQUENCES SOCIALES ET SANITAIRES DES CATASTROPHES

Les catastrophes entraînent de nombreuses conséquences sociales et sanitaires qui perturbent l'existence des victimes.

5.1 Conséquences sociales

- Les détériorations des infrastructures ;
- Les pertes d'habitations ou habitations endommagées entraînant la migration des populations vers des sites de fortune, abandonnant parfois tout ;
- Les perturbations du niveau et mode de vie conduisant souvent les populations les plus vulnérables à la prostitution, l'alcoolisme et la drogue.

5.2 Conséquences sanitaires

- Les décès et handicaps à vie consécutifs aux inondation et éboulements ;
- Les épidémies par la destruction des infrastructures socio-sanitaires de base (latrines, services de santé, système d'approvisionnement en eau potable, système d'évacuation des eaux usées, etc.) ;
- Les maladies nutritionnelles (malnutrition) par la destruction des systèmes de production agricole des populations.

VI. RÔLES DE L'INFIRMIER ET DE LA SAGE FEMME DANS LA GESTION DE CATASTROPHE DANS SON AIRE DE SANTE

Son rôle principal consiste à

- Donner l'alerte en informant le plus rapidement possible (téléphone, internet, etc.) au directeur départemental de la santé pour que des secours d'urgence soient organisés
- Apporter un soutien psychologique à la communauté victime de la catastrophe avant l'arrivée des secours

CONCLUSION

La gestion efficace et efficiente des catastrophes naturelles est d'une importance capitale car la survie de milliers de personnes en dépend. Dans cet élan de secours, l'infirmier et la sage-femme doivent être des acteurs actifs dans les actions de promotion de la santé, d'éducation, de prévention, de soins et de soutien à l'endroit des victimes.

LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE

Objectif général :

Ce cours vise à permettre à l'étudiant IDE/SF/M de la L3 d'initier la participation de la communauté aux actions de santé de son aire sanitaire.

Objectifs spécifiques :

Au terme de ce cours, il doit être capable de :

- 1) Définir les concepts composants la participation communautaire
- 2) Enoncer le but de la participation communautaire.
- 3) Citer les niveaux d'implication de la communauté dans la participation communautaire
- 4) Citer à partir du cours, les avantages de la participation
- 5) Enumérer selon le cours, les obstacles à la participation communautaire.

Introduction

Bien souvent, des programmes de santé communautaire échouent parce que tout simplement les planificateurs qui ont conçu ces programmes n'ont pas su exploiter le potentiel d'appui et de soutien que recèlent les communautés. Il y a donc participation communautaire lorsque la population locale exerce un contrôle total sur le processus ou décide entièrement par elle-même des activités qu'il convient d'entreprendre.

I. DÉFINITION DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE

L'OMS et l'UNICEF définissent la participation communautaire comme étant « un processus dans lequel les individus et les familles prennent en charge leur propre santé et leur propre bien-être comme ceux de la communauté, d'une part développent leur capacité de concourir à leur propre développement comme à celui de la communauté d'autre part » (UNICEF-OMS, 1978)

II. BUT DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE.

La **participation communautaire** contribue à l'autosuffisance, c'est-à-dire la capacité du groupe ou de l'individu à mobiliser les ressources internes et externes en vue de leur bien-être et afin d'avoir une emprise sur leur sort.

II. NIVEAUX D'IMPLICATION DE LA COMMUNAUTE : Elle est sollicitée dans :

- L'identification des besoins du développement sanitaire ;
- L'établissement des priorités et la définition des objectifs ;
- L'identification des solutions de rechange bien adaptées et fondées principalement sur les ressources et les technologies disponibles localement ;
- L'organisation de l'action communautaire ;
- La désignation des personnes chargées d'assurer les services nécessaires ;
- la prise de décisions relatives aux modalités de fonctionnement des services communautaires ;
- La recherche du soutien des personnes influentes et des chefs locaux, des agents de santé et des collectivités lors des transactions administratives ;
- L'auto-régularisations des activités de groupe ;
- À l'évaluation des services de santé communautaire et des apports individuels et collectifs.

IV. AVANTAGES DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE

Elle permet aux communautés :

- De concevoir leur état de santé objectivement plutôt qu'avec fatalisme et les incite à la prise des mesures préventives ;
- D'investir la main d'œuvre, du temps, de l'argent et des matériaux dans des activités de promotion de la santé ;
- D'utiliser et d'entretenir les ouvrages qu'elles ont construites ;
- D'étendre les activités de prestation des soins à la périphérie, etc.

V. OBSTACLES INFLUENCANT LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE

- Perception de la population sur les services de santé ;
- Faibles connaissances des organisations communautaires ;
- Rivalités inter villages, etc.

CONCLUSION

La participation communautaire est un processus dynamique qui est en évolution constante. Elle est le produit des changements continus dans les prises de décisions, dans le contrôle des ressources et dans les attitudes de ceux qui sont impliqués dans le programme

LA SUPERVISION

Objectif général

Ce cours vise à permettre à l'étudiant IDE/SF/M de la L3 de superviser les relais communautaires (ASC, AT)

Objectifs spécifiques

A la fin du cours, il doit être capable de

- 1) Définir la supervision
- 2) Citer les buts de la supervision.
- 3) Etablir la différence entre la supervision et les autres fonctions : inspection
Contrôle-monitorage-évaluation-coordination.
- 4) Décrire les différents styles de supervision
- 5) Citer les avantages de la supervision pour le supervisé, le superviseur et la structure sanitaire.
- 6) Décrire les méthodes et les approches de la supervision
- 7) Décrire les principaux outils du superviseur.
- 8) Décrire les différentes étapes de l'organisation d'une supervision.

INTRODUCTION

La supervision s'inscrit dans les activités de gestion des Soins de Santé Primaires (SSP). Sa finalité est la mise en œuvre des stratégies en vue de l'amélioration des prestations. Elle est importante en ce sens qu'elle permet de déceler chez l'agent supervisé, des insuffisances et d'apporter les corrections qui s'imposent, améliorant ainsi la qualité du travail accompli.

I. DÉFINITION DE LA SUPERVISION

La supervision est un processus continu qui consiste à guider et former l'agent de santé, soutenir et encourager ses initiatives sur le site du travail de sorte qu'il puisse l'exécuter avec efficacité et conformément aux directives.

II. BUTS DE LA SUPERVISION

- Promouvoir l'amélioration continue de la performance du personnel de santé ;
- Promouvoir un esprit de stimulation ;
- Vérifier si l'objectif défini par un programme peut être atteint ;

III. DIFFERENCES ENTRE LA SUPERVISION ET LES AUTRES FONCTIONS

Concepts	Cible	Issus	Acteurs	Moment	Gradient d'autorité
Inspection	Etablissement et / ou personnel	Appréciation positive ou négative	Inspecteur ou délégués	Programmée ou à l'improviste	+++
Contrôle	Personnel Etablissement Matériel	Conforme ou non	Hiérarchie et/ ou technicien	A tout moment	+++
Supervision	Personnel en activité	Amélioration de la compétence, de la qualité de service, du rendement	Supérieur Hiérarchique	Annoncé et périodique	+
Monitoring	Activité selon les directives	Apporter les corrections aux goulots d'étranglements	La hiérarchie et/ou les prestataires	Périodique	+/-
Evaluation	Cible universelle	Améliorer la mise en œuvre	Expert	Ponctuelle ou continue	+/-
Coordination	Activités	Harmoniser	Chef de service	Permanente	++

IV. LES DIFFERENTS STYLES DE SUPERVISION

4.1 Le style autocratique

Dans ce style, le superviseur cherche à tout voir, tout savoir et tout comprendre. Il ne délègue pas de responsabilité. Il donne des instructions spécifiques et surveille de près l'exécution des tâches.

4.1.1 *Avantage*

- Il permet d'atteindre une performance élevée.

4.1.2 *Inconvénients*

- Réduction de la qualité du rendement à l'absence du superviseur ;
- Sensation de manque de confiance, frustration.

4.1.3 *Circonstances d'application*

- Situations d'urgence qui exigent une prise de décisions sans délai ;
- Situation dans laquelle l'application d'une certaine stratégie est cruciale ;
- Situation de blocage.

4.2 Le style démocratique ou participatif

Dans ce style, le superviseur fait participer ses collaborateurs à la planification des activités et des projets. Il les aide à prendre des décisions. Il reconnaît et encourage certaines initiatives prise par le supervisé.

4.2.1 Avantages

- Augmente le rendement de façon durable ;
- Est motivant et aide à prendre des décisions ;
- Encourage les initiatives et permet une bonne coordination des activités.

4.2.2 Inconvénients

- Risque de lenteur dans l'obtention des résultats ;
- Risque d'anarchie.

4.2.3 Circonstances d'application

- S'applique à toutes les situations, excepté les situations d'urgence et de blocage.

4.3 Le style « laisser-faire »

C'est l'inverse du style autocratique. C'est le type de style où le superviseur fait confiance à ses collaborateurs et les laisse faire. Son souci est de contenter tout le monde.

4.3.1 Avantages

- Favorise la créativité et l'esprit d'initiative ;

4.3.2 Inconvénients

- Manque de coordination des activités ;
- Négligence des tâches importantes ;
- Existence de risque d'anarchie.

4.3.2 Circonstance d'application

- S'applique aux situations de recherche et en présence d'un agent consciencieux et compétent.

V- AVANTAGES DE LA SUPERVISION

5.1 Avantages pour le supervisé.

- Se sentir responsabiliser, valoriser, stimuler, appartenir à une équipe ;
- Se rendre compte de son rendement ;

- Etre conscient de ses déficiences et de ses lacunes ;Avoir la possibilité de discuter de ses problèmes avec ses supérieurs hiérarchiques, etc.

5.2 Avantages pour le service :

- Accroître l'efficacité, l'efficacité et la qualité du service ;
- Adapter l'exécution des activités et l'utilisation des ressources humaines financières et matérielles ;
- Permettre une meilleure organisation du service, etc.

5.3 Avantages pour le superviseur

- Se rendre compte de la manière dont les tâches déléguées sont exécutées ;
- Avoir une meilleure connaissance des conditions de travail des collaborateurs ;
- Identifier les problèmes rencontrés pendant l'exécution des activités, etc.

VI- METHODES ET APPROCHES DE LA SUPERVISION

6.1 Méthodes de la supervision

6.1.1 Méthode directe

C'est la méthode où l'on procède par observation directe de l'agent de santé pendant l'exécution d'une tâche donnée sans intervenir sauf si le geste met en danger la vie du malade.

6.1.2 Méthode indirecte

C'est la méthode où l'on procède par l'interrogatoire des utilisateurs de la structure sanitaire ou par analyse des supports de données.

6.2 Approches de la supervision

La supervision proprement dite comprend essentiellement deux parties :

- L'observation ;
- La correction.

6.2.1 L'observation

Elle consiste à :

- Observer avec objectivité et lucidité, en se référant aux éléments retenus sur la fiche d'observation ;
- Relever ce que l'agent de santé fait et faire la comparaison avec les normes préalablement retenues ;

- Analyser les points relevés ; si lacunes, si insuffisances, les rapporter à l'un des trois domaines : « savoir », « savoir-faire » et savoir être » ;
- Décider s'il faut entreprendre les actions et quand pour corriger les lacunes et les insuffisances constatées.

2.2 La correction

La correction consiste à décider des mesures à prendre soit immédiatement, soit en différé

Immédiatement pour corriger les déficiences et lacunes ou proposer des directives et encourager l'agent ;

En différé pour proposer un plan de formation ou de renforcement de capacité.

VII PROFIL DU SUPERVISEUR

7.1 Un bon superviseur doit être :

- Honnête c'est-à-dire intègre, loyal ;
- Dynamique c'est-à-dire entreprenant ;
- Flexible c'est-à-dire souple et non rigide ;
- Disponible c'est-à-dire libre, prêt.

7.2 Un bon superviseur doit avoir :

- Une capacité d'imagination ;
- Une capacité de communication ;
- Une capacité de contrôle de soi ;
- Un esprit d'équipe.

VIII. LES OUTILS DU SUPERVISEUR

8.1 Le classeur du superviseur.

Il renferme l'ensemble des documents administratifs (décrets, arrêtés...) et techniques (guide de supervision, ordinogramme, directives du PMA...) à l'exécution de la supervision.

8.2 Le classeur de la formation sanitaire

Il renferme les informations importantes et nécessaires ainsi que les données sanitaires de la structure (cartographie, rapports mensuels et annuels de morbidité, synthèse des supervisions antérieures, etc.)

8.3 Le cahier à problèmes de la formation sanitaire

C'est un document où sont notés les problèmes inhérents au fonctionnement du centre et se rapportant au personnel de santé (vie au centre, les difficultés etc.).

Il est rempli par l'infirmier du centre et doit être consulté à chaque supervision par le superviseur.

8.4 La fiche de synthèse des résultats de la supervision

C'est dans ce document que la synthèse de la supervision est faite. Elle sert d'instrument à la prise de décision.

8.5 La fiche de supervision ou d'observation

C'est la fiche qui sert de fil conducteur à l'observation de l'exécution d'une tâche donnée (Exemple : injection intra musculaire)

IX- LES DIFFERENTES ETAPES POUR L'ORGANISATION D'UNE SUPERVISION

9.1 Phase préparatoire ou phase d'étude de la documentation disponible

Elle consiste à rechercher toutes les informations utiles pour effectuer une bonne supervision. Elle permet au superviseur :

- D'identifier les écarts entre les différentes couvertures et les normes prévues.
- de relever les écarts les plus significatifs et formuler une série d'hypothèses concernant les causes possibles des écarts relevés ;
- D'identifier l'état de résolution des problèmes relevés lors des supervisions précédentes ;
- De préparer une liste des points à superviser sur la base des hypothèses émises de manière à confirmer ou infirmer ces hypothèses ;
- D'établir un calendrier de supervision et le ventiler à temps avec l'objet de la supervision
- D'apprêter les outils et les ressources nécessaires à la supervision

9.2 Phase d'exécution

- Saluer avant toute supervision les autorités administratives et politiques, les chefs de village etc.
- Prendre connaissance des problèmes du personnel (cahier à problèmes)
- Faire le point sur l'état d'avancement des dernières recommandations (fiche de synthèse)

- Observer l'exécution des tâches par l'agent supervisé (fiche d'observation)
- Faire la synthèse de la supervision avec le supervisé à la fin de la supervision (fiche de synthèse)
- Remplir deux fiches de synthèse qui doivent être signées conjointement par le superviseur et le supervisé.

9.3 Phase d'exploitation

9.3.1 L'exploitation immédiate

Elle consiste à faire des recommandations justes après la supervision. L'avantage de cette méthode est qu'elle permet une meilleure compréhension des tâches que le supervisé doit exécuter selon les instructions et à créer un climat de confiance réciproque et de transparence.

9.3.2 L'exploitation différée

Elle se fait au niveau du district sanitaire après la supervision. Une rétro information est faite au supervisé et un compte rendu aux membres de l'équipe cadre du District.

9.4 Phase du Suivi évaluation

Elle concerne les recommandations à cours, moyen et long terme faites après la supervision.

9.4.1 Au niveau du suivi

Le chef de l'équipe de supervision en collaboration avec les autres membres doit veiller à la mise en œuvre des recommandations et identifier si possible les besoins de formation ou de renforcement de capacités.

9.4.2 Au niveau de l'évaluation

L'équipe de supervision doit s'auto évaluer pour :

- S'enquérir de l'atteinte des objectifs fixés par l'équipe de supervision ;
- Relever les insuffisances et rechercher les solutions ;
- Analyser les progrès réalisés d'une supervision à une autre.

CONCLUSION

Tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il ne peut y avoir de bons services de santé sans un personnel bien formé aux tâches qui sont les siennes. Si une formation initiale adéquate est indispensable à tout personnel de santé, elle ne saurait en aucune façon être

suffisante. La formation doit être complétée et adaptée aux milieux et aux circonstances nouvelles.

Elle doit revêtir une certaine continuité et permettre de suivre, encadrer, guider l'agent et corriger ses insuffisances. Une supervision qui est formative n'est pas une simple visite à l'agent de santé. Elle exige donc de celui qui la fait beaucoup plus de qualités et de valeurs psychologiques, affectives et morales.

SUIVI ET EVALUATION DE PROGRAMME ET PROJET DE SANTE & INDICATEURS ET SOURCES DE DONNES

A : SUIVI & EVALUATION

Objectif général

Ce cours vise à permettre à l'étudiant IDE/SF/M de la L 3 de suivre et d'évaluer les programmes et projets de santé

Objectifs spécifiques

A la fin du cours du cours, il doit être capable de :

- 1) Définir les concepts suivants : Programme, projet, suivi, évaluation.
- 2) Etablir la différence entre le suivi et l'évaluation
- 3) Déterminer l'importance du suivi et évaluation
- 4) Définir les composantes d'un projet/ programme.
- 5) Identifier les types de suivi et évaluation.

I. DÉFINITIONS DES TERMES LIÉS AU SUIVI ET ÉVALUATION

1.1 Programme

Un programme est une série cohérente de politiques, stratégies, activités et d'investissements destinés à atteindre un objectif national ou une série d'objectifs nationaux de développement dans un délai précis.

1.2 Projet

Un projet est un ensemble de moyens mis en œuvre pour réaliser un objectif spécifique du programme dans un délai déterminé.

1.3 Suivi

Un processus continu de collecte et d'analyse d'informations sur un projet ou un programme en cours de réalisation afin d'identifier les progrès réalisés et les difficultés rencontrées.

1.4 Evaluation

C'est un exercice limité dans le temps qui vise à mesurer objectivement l'impact (résultats) attribuable à l'intervention du programme/projet.

II. DIFFÉRENCES ENTRE SUIVI ET ÉVALUATION

SUIVI	EVALUATION
Le suivi est une mesure continue du rendement (monitorage). C'est le tableau de bord qui fournit des informations régulières sur le fonctionnement d'un programme ou projet	L'évaluation est la mesure des effets et de l'impact. Elle intervient seulement après un certain délai et demande des investigations plus approfondies.
Ils sont complémentaires	
Démarche dans le suivi est différente de la démarche dans l'évaluation	

III. IMPORTANCE DE SUIVI ET EVALUATION

Le suivi et évaluation est une étape très importante dans la planification des activités d'un programme. Le suivi et évaluation :

- Fournit aux organisations un outil pour mesurer l'efficacité et l'efficience des programmes ;
- Dote les gestionnaires d'un outil pour obtenir des informations à temps sur l'évolution des activités d'un programme, qui leur permettent de comparer ce qui était prévu à ce qui a été réalisé ;
- Favorise l'apprentissage dans l'organisation et encourage la gestion adaptée ;
- Suscite la coopération du public et des politiques et répond aux besoins d'information sur le public cible.

IV. COMPOSANTES D'UN PROGRAMME OU PROJET

4.1 Intrants

Ce sont les ressources utilisées dans le cadre d'un programme ou projet. Ce sont les ressources financières, humaines, matérielles, les protocoles et directives, les supports de formation, les médicaments, etc.

4.2 Processus

Ce sont les activités que le programme ou projet mènent pour atteindre ses objectifs, Il concerne la sensibilisation, la distribution de supports, les séances de counseling, les ateliers et formations, la supervision, la distribution des moustiquaires imprégnées à longue durée d'action, etc.

4.3 Extrant

Ce sont les produits directs ou produits livrables du programme ou projet. Ce sont les nombres de séances d'interventions réalisées, les personnes atteintes ou les supports éducatifs distribués, le nombre d'agents formés, etc.

4.4 Effets

Ce sont les résultats du programme qui se produisent aussi bien immédiatement qu'un certain temps après l'achèvement des activités. Il s'agit des changements au niveau des connaissances, des attitudes, des croyances, des compétences, comportements, de l'accès aux services, des politiques.

4.5 Résultats/impact

Ce sont les résultats à long terme d'un ou de plusieurs programmes, dans le temps tels que les changements au niveau de l'infection, de la morbidité, la diminution des taux de transmission du VIH, la diminution de l'incidence du VIH, la diminution de la morbidité et de la mortalité dues au VIH, etc....

V. TYPES DE SUIVI ET ÉVALUATION

3.1 Types de suivi

3.1.1 Suivi d'intrants/extrants

Elle consiste à recueillir les données décrivant les individus servis, les services fournis et les ressources utilisées pour fournir ces services. Il permet de répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les services qui ont été fournis ?
- Quelle est la population qui a été desservie et combien d'individus ont-ils été servis ?
- Quels personnels/ressources ont-ils/elles été utilisé(es)?

3.1.2 Suivi de processus

Elle consiste à recueillir et analyser des données plus détaillées sur les modalités d'exécution de l'intervention. Il répond aux questions telles que :

- L'intervention prévue a-t-elle été exécutée ?
- L'intervention a-t-elle touché le public ciblé, etc. ?

3.1.3 Suivi des effets.

Il permet de savoir si les résultats escomptés se sont produits ? Il répond aux questions suivantes

- Les connaissances escomptées ont-elles été acquies ?
- Le changement de comportement attendu s'est-il produit ?
- L'utilisation des services par les clients s'est-elle produite ?

3.2 Types d'évaluation

3.2.1 Évaluation initiale (Analyse situationnelle)

Elle consiste en une collecte d'informations et de données nécessaires pour planifier les programmes/projets et les initiatives. Ces données peuvent décrire les besoins de la population, les facteurs de risque, le contexte, la réponse du programme et les ressources disponibles (financières et humaines).

Elle permet de répondre aux questions telles que :

- Quels sont les besoins des populations que le programme/ projet ou l'initiative devra atteindre ?
- Comment le programme/ projet ou l'initiative devrait-il/elle être conçu(e) ou modifié(e) pour répondre aux besoins des populations ?
- Quelle serait la meilleure manière d'exécuter ce programme/projet ou initiative

3.2.2 Évaluation d'effets

Elle consiste à collecter et analyser les données utilisées pour déterminer si une intervention a réalisé ses résultats prévus et de quelle manière. « L'intervention a-t-elle donné les résultats attendus ? »

3.2.3 Évaluation d'impact

Elle consiste à recueillir des données sur l'infection à VIH au niveau régional et national. Une évaluation d'impact viserait à démontrer que le changement de comportement est imputable au projet et a eu un impact en termes de transmission réduite du VIH.

CONCLUSION

En conclusion, le suivi évaluation est un outil essentiel pour prendre des décisions éclairées concernant la conduite des opérations et la fourniture de services, de garantir l'utilisation la plus efficace et efficiente des ressources, de déterminer à quel point le programme/projet respecte son chronogramme et apporter en conséquence les corrections nécessaires. Cet outil permet également d'évaluer dans quelle mesure le programme/projet est en cours de réalisation ou a déjà atteint l'impact voulu.

B- INDICATEURS ET SOURCES DE DONNEES

Objectif général

Ce cours vise à permettre à l'étudiant IDE/SF/M de la L3 d'améliorer la performance d'un projet ou programme de santé à travers la maîtrise des indicateurs et des sources de données.

Objectifs spécifiques

A la fin du cours, il doit être capable de :

- 1) Définir les termes suivants : indicateur - source de données
- 2) Décrire les caractéristiques d'un bon indicateur
- 3) Citer les principales sources de données pour la collecte des indicateurs
- 4) Enumérer les critères de sélection d'un indicateur.
- 5) Décrire les différents types d'indicateurs

INTRODUCTION

La bonne gestion d'un projet/programme repose sur la collecte et l'analyse des données fiables pour prendre des décisions et améliorer la mise en œuvre des interventions. Ces données collectées au niveau des projets/programmes sont les indicateurs.

I. DÉFINITIONS

1.1 Indicateur

C'est une variable quantitative ou qualitative simple qui mesure un aspect d'une intervention en santé, programme ou projet.

1.2 Sources de données

Ce sont des documents susceptibles de fournir des données fiables permettant de calculer un indicateur donné.

II.PRINCIPALES SOURCES DE DONNEES

Les principales sources de données pour la collecte des indicateurs sont :

2.1 Les rapports du projet / programme

- Rapport d'activités ;
- Rapport financier ;
- Rapport de formation ;
- Rapport d'assistance technique, etc.

2.2 Les registre

- Registre de consultation ;
- Registre de laboratoire ;
- Registre de gestion des stocks ;
- Registre des décès, etc. ;

2.3 Les rapports d'enquête

- Enquête de service ;
- Enquête de surveillance ;
- Enquête de comportement ;
- Enquête démographique de santé, recensement de la population, etc.).

2.4 Les rapports d'activités

- Rapport de mission ;
- Rapport de supervision ou de visite de terrain ;
- Rapport d'étude ;
- Rapport d'analyse situationnelle.

2.5 Les rapports d'évaluation

- Rapport d'audit ;
- Rapport d'inventaire ;
- Rapport d'évaluation de performance ou de compétences.

2.6 Les documents administratifs et financiers officiels.

- Journal officiel ;
- Budget national ;
- Autres documents officiels.

2.7 Cartes et graphiques officiels

- Carte à risque ;
- Carte cadastrale ;
- Graphique linéaire et modèle d'élévation numérique.

III. CARACTÉRISTIQUES D'UN BON INDICATEUR

Un bon indicateur doit respecter les caractéristiques SMART suivantes :

Spécifique : un indicateur doit être concret, détaillé, centré sur un aspect, et bien défini.

Mesurable : à partir des sources identifiées, l'indicateur précise combien de fois et comment il doit être calculé.

Acceptable : les parties prenantes impliquées dans un modèle spécifique de suivi-évaluation devraient tous accepter que les indicateurs choisis sont pertinents

Réalisable : l'indicateur doit générer des données qui peuvent répondre aux questions d'intérêt.

Temporellement défini : l'indicateur doit spécifier la périodicité et les moments où il doit être mesuré .

IV- CRITERES DE SELECTION D'UN INDICATEUR

4.1 La disponibilité des données

Il s'agit de s'assurer que les données relatives au calcul de l'indicateur existent et sont disponibles.

4.2 La disponibilité des ressources

Il s'agit de s'assurer que les ressources existantes permettent de collecter et d'analyser les données.

4.3 Les besoins en information

Il s'agit de s'assurer que l'indicateur montre les résultats du projet/programme et qui servent à une meilleure prise de décision, planification, exécution, suivi et évaluation du projet/programme

4.4 Les exigences des bailleurs de fonds

Il s'agit de s'assurer que les indicateurs à retenir prennent impérativement en compte les préoccupations du bailleur de fonds (besoins en information)

V. LES DIFFERENTS TYPES D'INDICATEURS

De manière générale, on distingue quatre types d'indicateurs résumés dans le tableau suivant :

Types d'indicateurs	Description	Niveau
Indicateurs d'intrants	Les intrants sont les ressources humaines, financières, techniques, matérielles et informationnelles que nous devons apporter pour réaliser les activités d'un projet/programme. Exemples : ▪ Le budget alloué aux activités ; ▪ Le nombre de véhicules achetés ; ▪ Le nombre de kits d'IST disponibles ;	Les intrants du projet /programme
Indicateurs de processus	Ils sont liés aux activités et permettent de mesurer ce qui se passe durant l'exécution des activités du projet /programme. Exemple : ▪ Le nombre de sessions de formation organisées ; ▪ Le nombre de kits d'IST distribués.	Les activités du projet /programme (exécution)
Indicateurs de réalisation	Ils permettent de mesurer les réalisations immédiates de la mise en œuvre de l'activité. Exemple : ▪ Le nombre de personnes formées ; ▪ Le nombre de cas d'IST traités.	Les activités du projet /programme
Indicateurs de résultat	Les résultats sont les changements de comportement ou d'acquisition de compétences. Ce sont les effets constatés à moyen terme d'un projet/programme. Exemple : ▪ Le pourcentage des jeunes de 15 à 24 ans utilisant correctement le préservatif.	Les résultats ou objectifs spécifiques du projet /programme
Indicateurs d'impact	Ce sont les effets mesurables à long terme. En termes de santé, ce sont notamment : Exemples : ▪ La réduction de 35% la transmission du VIH de la mère l'enfant ; ▪ La réduction de 25% la transmission des IST/VIH chez les jeunes ;	Objectif général du projet /programme

ORGANISATION D'UNE SEANCE DE VACCINATION

Objectif général

Ce cours vise à permettre à l'étudiant IDE /SF/M de la L3 d'organiser correctement une séance de vaccination pour offrir un service de qualité

Objectifs spécifiques

A la fin du cours, il doit être capable de :

- 1) maîtriser la préparation d'une séance de vaccination
- 2) évaluer l'état vaccinal de la mère et de l'enfant
- 3) procéder à l'enregistrement des vaccins
- 4) maîtriser l'administration des vaccins en toute sécurité
- 5) maîtriser la communication avec les parents lors des séances de vaccination
- 6) procéder à la clôture d'une séance de vaccination

I. PRÉPARATION D'UNE SÉANCE DE VACCINATION

Elle consiste à :

1.1 Conditionner les accumulateurs au moins 30 minutes avant la séance ;

- Retirer les accumulateurs congelés du compartiment congélateur au moins 30 minutes avant le début de la séance ;
- Laisser les accumulateurs à la température ambiante jusqu'à ce que la glace commence à fondre et que de l'eau commence à se former à l'intérieur ;
- Vérifier si l'accumulateur contient de l'eau en le secouant et en écoutant le bruit de clapotis

1.2 Retirer les vaccins du réfrigérateur

- Estimer le nombre de dose pour chaque vaccin
- Sortir les vaccins du réfrigérateur dans l'ordre suivant :
 1. Les flacons entamés et bien conservés ;
 2. Les flacons et diluants sortis et non ouverts lors de la précédente séance fixe ou avancé et remis dans la réfrigération après la séance ;
 3. Les vaccins dont la PCV commence à changer de couleur ;
 4. Les vaccins les plus anciens mais qui n'ont pas encore atteint leur date limite d'utilisation.

1.3 Vérifier si les vaccins sont utilisables

- Contrôler chaque vaccin et son diluant ;
- Vérifier les étiquettes du vaccin et du solvant : les jeter s'ils n'en ont pas ;
- Vérifier la date limite d'utilisation : jeter les flacons et solvants si la date limite d'utilisation est dépassée ;
- Vérifier la pastille de contrôle du vaccin (PCV) : jeter si stade 3 ou 4 ;
- Vérifier si l'indicateur de congélation présente un risque de congélation ou suspicion de gel d'un vaccin sensible (DT, HepB, DTC-HepB+Hib.), il faut faire le test d'agitation

1.4 Interpréter la pastille de contrôle

Figure 6A : Ce que la pastille de contrôle du vaccin indique



Le carré est plus clair que le cercle.
Si la date limite d'utilisation n'est pas dépassée, UTILISER le vaccin.



Un peu plus tard, le carré est toujours plus clair que le cercle.
Si la date limite d'utilisation n'est pas dépassée, UTILISER le vaccin.



Point limite
Le carré est de la même couleur que le cercle.
NE PAS utiliser le vaccin. Avisez votre superviseur.



Au-delà du point limite
Le carré est plus sombre que le cercle.
NE PAS utiliser le vaccin. Avisez votre superviseur.

1.5 Préparer le poste de travail

- Aménager l'espace réservé à la vaccination ;
- Pour gérer le flux des femmes et permettre de travailler avec rapidité, l'espace doit être
 - Facile d'accès pour les utilisateurs (femmes et nourrissons) ;
 - Aménagé de sorte que ceux-ci ne s'agglutinent pas dans la zone de vaccination ;

- Situé dans un endroit qui n'est pas exposé directement au soleil, ni à la pluie et à la poussière ;
 - Commode pour l'agent de santé qui prépare et l'administre le vaccin ;
 - Suffisamment calme pour une bonne communication avec les femmes.
- Rassembler le matériel d'injection : seringue, aiguille...
 - Rassembler les outils de collecte : registre de vaccination, fiche de pointage, fiche de synthèse...
 - Préparer le dispositif d'hygiène : eau, savon liquide...
 - Rassembler le matériel de sécurité d'injection : boîte de sécurité, sac poubelle...
 - Disposer le mobilier : table, banc, chaise

1.5.1 Quelques indications pour l'aménagement de l'espace

- Ne pas utiliser la même table pour la vaccination et les autres interventions de santé si ces dernières ont lieu en même temps que la vaccination ;
- L'agent vaccinateur doit se placer entre le nourrisson et toutes les aiguilles et autres objets tranchants ;
- Chaque agent vaccination doit avoir sa propre boîte de sécurité dans les postes de vaccination très fréquentés ;
- Le matériel pour se laver les mains doit être disposé juste à côté de la table de vaccination ;
- Les agents vaccinateurs doivent se laver les mains avant de pratiquer la première vaccination et chaque fois qu'ils seront en contact avec des souillures ou du sang.

1.5.2 Aménagement d'un Poste en stratégie avancée

- **Site de vaccination** : c'est un espace géographique bien délimité (avec une population bien déterminée) couvert par une équipe de vaccination ;
- **Poste de vaccination** : représente un lieu choisi pour installer l'équipe de vaccination ;

NB : le poste de vaccination doit être spacieux, aéré, à l'ombre ou si possible couvert

1.5.3 Différents compartiments d'un poste de vaccination

- Zone d'entrée /attente : vérification des carnets et des RDV ;
- Zone d'enregistrement : pointage sur les fiches et remplissage du registre de vaccination et des carnets de santé mère enfant ;
- Zone de vaccination : administration des vaccins ;
- Zone de sortie : une sortie pour tous.

NB : La zone d'entrée doit être différente de la zone de sortie

1.5.4 Matériels aux différents compartiments du poste

- Zone d'entrée /attente : bancs, chaises
- Zone d'enregistrement :
 - Tables, chaises, carnets de sante mère enfant, registre de vaccination, fiches de pointage, stylos
- Zone de Vaccination :
 - Tables, chaises ;
 - Porte - vaccins contenant des accumulateurs ;
 - SAB, BS, sac poubelle ;
 - Coton, bidon d'eau propre, savon ;
 - Répertoire des points focaux MAPI et communication.

II. EVALUATION DE L'ETAT VACCINAL DES CIBLES (Poste de tri)

2.1 Déterminer si l'enfant doit recevoir des vaccins :

- Déterminer l'âge (carnet, interrogatoire) ;
- Evaluer l'état vaccinal : vérification du carnet ou registre de vaccination, ou interrogatoire de la mère, présence de cicatrice ;
- Recenser tous les vaccins que le nourrisson peut recevoir :
 - Si plus d'un vaccin : administrer tous à la même séance avec les injections en des points différents ;
 - Pour les vaccins multi doses, administrer la dose suivante : ne pas reprendre la série de vaccination si l'intervalle minimum est respecté entre les doses

Par exemple :

Un enfant de 9 mois qui n'a reçu que le BCG, le VPO1 et le DTC-HepB-Hib 1 est vue à la présente séance, il recevra le VPO2, le DTC-HepB-Hib 2 , le vaccin RR et le vaccin antiamaril. Ensuite on expliquera à la mère qu'il est important qu'elle ramène l'enfant dans quatre semaines pour qu'il reçoive le VPO3 et le DTC-HepB-Hib 3.

2.2 Déterminer si la femme doit recevoir le vaccin antitétanique

- Demander à la femme tout d'abord si elle a une carte de vaccination/ carnet de santé mère enfant :
 - Si elle en a une, lui administrer la dose requise conformément au calendrier national ;
 - Si elle n'en a pas, lui demander si elle a reçu une dose de vaccin antitétanique (VAT/ Td) dans le passé.
- Enregistrer les doses de vaccin antitétanique (VAT/ Td) administrées sur la fiche de pointage, dans le registre et dans le carnet de santé mère enfant

III. ENREGISTREMENT DE VACCINS (Poste d'enregistrement)

- Remplir correctement les carnets de santé mère enfant ;
- Noter dans le carnet de santé mère enfant le ou les vaccins administrés, les numéros de lot et la date d'administration ;
- Noter la date de la prochaine vaccination et indiquer aux parents où et quand ils doivent revenir pour la prochaine vaccination ;
- Remplir le carnet de santé mère enfant de la femme enceinte ;
- Expliquer aux parents l'intérêt à bien conserver le carnet de santé mère enfant ou la carte de vaccination et le présenter à la prochaine séance de vaccination.

IV. ADMINISTRATION DES VACCINS ENTOUTE SECURITE (Poste de vaccination proprement dite)

4.1 Reconstitution des vaccins :

- Utiliser les solvants appropriés ;
- Utiliser le solvant du même fabricant que le vaccin ;
- Refroidir les solvants avant de les mélanger au vaccin.

4.2 Vaccins à reconstituer : BCG, RR, VAA, Men A

Les vaccins reconstitués doivent être jetés au bout de 6 heures

4.3 Voies d'administration des différents vaccins

Antigènes	Voie d'administration	Site d'administration
BCG,	Intra dermique	Bras gauche
DN Hépatite B	Intramusculaire	Face antérolatérale de la cuisse
DTC-Hép B - Hib	Sous cutané	Bras gauche (deltoïde)
VPI	Intra Musculaire	Cuisse gauche (face latero externe)
RR, VAA	sous cutané	Deltoïde (bras gauche)
PCV 13	Intra Musculaire	Cuisse droite (face latero externe)
Men AFRIVAC	Intra Musculaire	Cuisse gauche (face latero externe)
VPO	Orale	Bouche
Rota	Orale	Face interne de la joue
Vaccin contre le Papilloma virus humain	Intramusculaire	Région du deltoïde (partie supérieure) du bras gauche
Td	Intra Musculaire	Bras gauche (deltoïde)

4.4 Après l'administration des vaccins

- Cocher sur la fiche de pointage les vaccins administrés ;
- Noter chaque vaccin sur la fiche de pointage selon les directives dès que vous avez fini d'administrer le vaccin.

V.COMMUNICATION PENDANT ET APRÈS LA VACCINATION (Poste de CCSC)

- Remercier le parent d'être venu à la séance de vaccination et de sa patience s'il a dû attendre ;
- Expliquer en termes simples les maladies contre lesquelles les vaccins protègent ;
- Décrire quels sont les effets secondaires de la vaccination et ce qu'il y a lieu de faire ;
- Pour les vaccins à doses multiples, expliquer que le nourrisson doit recevoir toute la série pour être complètement vacciné ;
- Expliquer aux femmes combien de fois, où et quand elles doivent revenir se faire vacciner pour être complètement protégées contre le tétanos ;
- Rappeler aux parents de toujours apporter leurs carnets de santé mère enfant ou cartes de vaccination au centre de santé ou aux séances de vaccination en stratégie avancée ;

- Si le nourrisson (ou sa mère) a manqué certaines séances, ne pas réprimander la mère. Il faut lui :
 - expliquer pourquoi il est important que le nourrisson et elles soient complètement vaccinés ;
 - dire que vous allez lui administrer (dans la mesure du possible) les doses manquantes au cours de cette séance ;
 - demander également de venir en temps voulu pour les vaccinations suivantes (donner un rendez-vous)
- Informer le parent de toutes les activités supplémentaires de vaccination (JNV contre la polio ...) à venir ;
- Informer le parent sur les effets secondaires ;
- Demander au parent de ramener l'enfant en cas d'effets secondaires ;
- Demander au parent s'il a des questions ;
- Assurez-vous que vous avez répété chacun de ces messages à plusieurs reprises si cela semble nécessaire.

VI. CLÔTURE DE LA SÉANCE DE VACCINATION

- Evaluer la séance de vaccination ;
 - Compter le nombre de doses de chaque type de vaccin administré ;
 - Compter le nombre de doses restantes pour chaque type de vaccin ;
 - Calculer la couverture (cible vaccinée/cible attendue) ;
 - Etablir la liste de ceux qui n'ont pas répondu à leur rendez-vous.
- Ranger les vaccins non utilisés ;
- Etiqueter les flacons ouverts et réutilisables (vaccin liquide) ;
- Détruire les déchets.

QUELQUES CONSEILS

- **Pratiques à éviter pendant une séance de vaccination pour la sécurité des injections**
- ✓ **Les personnes qui reçoivent les injections**
 - Réutiliser une seringue ou une aiguille ;
 - Changer l'aiguille, mais réutiliser la seringue ;
 - Stériliser et réutiliser une seringue jetable ;
 - Appuyer sur le point de saignement avec du matériel usagé ou le doigt.
- ✓ **Pour les agents de santé (gestes à ne jamais faire)**
 - Recapuchonner les aiguilles ;
 - Détacher l'aiguille de la seringue avec la main ;
 - Placer les aiguilles sur une surface et les transporter sur une certaine distance avant de les jeter ;
 - Plonger la main dans une grande quantité de seringues ou d'aiguilles (pour nettoyer ou trier les déchets).
- ✓ **Pour la communauté**
 - Laisser les seringues usagées dans des endroits où les enfants peuvent avoir accès ;
 - Donner ou vendre des seringues déjà utilisées ;
 - Laisser les seringues usagées dans des endroits accessibles au public.
- **Mesures à observer pour éviter les MAPI pendant une séance de vaccination**
 - Vérifier l'intégrité du flacon (fissure, fermeture) ;
 - Vérifier sur les étiquettes des flacons (PCV, date de péremption, etc.) ;
 - Vérifier si le vaccin n'est pas exposé à la contamination (suspension, couleur.) ;
 - Vérifier l'exposition à la chaleur et au gel (thermomètre, accumulateurs) ;
 - Vérifier l'étanchéité de l'emballage pour :
 - savoir si la qualité des seringues et vaccins est douteuse ;
 - ôter le flacon qui n'a pas d'étiquette ;
 - ôter le flacon de vaccin entamé.

